

PENYERTAAN PROGRAM PSI-SEGAR DALAM MEMELIHARA KESEHATAN FISIK DAN MENTAL GUNA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP LANSIA DI KOMUNITAS

Nunuk Sri Purwanti
Abdul Ghofur



Penyertaan Program Psi-Segar dalam Memelihara Kesehatan Fisik dan Mental Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia di Komunitas

Penulis:

Dr. Nunuk Sri Purwanti, S.Kp., M.Kes.

Dr. Abdul Ghofur, S.Kp., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Penyertaan Program Psi-Segar dalam Memelihara Kesehatan Fisik dan Mental Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia di Komunitas

Penulis: Dr. Nunuk Sri Purwanti, S.Kp., M.Kes.
Dr. Abdul Ghofur, S.Kp., M.Kes.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7139-10-8

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul ***“Penyertaan Program Psi-Segar (Psikoedukasi - Senam Bugar Lansia) dalam Memelihara Kesehatan Fisik dan Mental Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia di Komunitas”*** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia di komunitas melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan psikoedukasi dan senam bugar dengan memanfaatkan kearifan lokal. Lansia merupakan kelompok populasi yang memerlukan perhatian khusus, mengingat tantangan yang dihadapi lansia, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, program Psi-Segar hadir sebagai sebuah inovasi yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung lansia agar tetap aktif, sehat, dan memiliki semangat hidup serta kualitas hidup yang tinggi.

Isi buku ini mencakup landasan teori yang mendasari program Psi-Segar, tahapan perancangan dan implementasi program, hingga hasil evaluasi yang menunjukkan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental lansia. Selain itu, buku ini juga menyajikan panduan praktis bagi komunitas atau tenaga kesehatan yang ingin mengadopsi program ini dalam upaya pemberdayaan lansia di wilayah masing-masing.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Harapan kami, buku ini dapat bermanfaat bagi

berbagai kalangan, terutama praktisi kesehatan, akademisi, dan pihak-pihak yang peduli terhadap kesejahteraan lansia di komunitas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu langkah kecil dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi para lansia di Indonesia.

Januari, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata..... iii

Daftar Isi..... v

Bab 1 Pendahuluan 1

Bab 2 Konsep Kesehatan Lansia 11

A. Definisi Lansia..... 11

B. Proses Menua..... 13

C. Kualitas Hidup Lansia 15

Bab 3 Psikoedukasi Lansia 35

A. Pengertian psikoedukasi..... 35

B. Fokus Psikoedukasi 38

C. Psikoedukasi pada lansia 38

D. Teori perlunya program psikoedukasi dan senam
bugar lansia..... 41

Bab 4 Senam Sehat Bugar Lansia 49

A. Aktivitas fisik..... 49

B. *Physical exercise* (latihan fisik) 53

C. Aspek-aspek pendukung aktivitas fisik / senam lansia
..... 56

D. Kearifan lokal dalam promosi kesehatan melalui
Program Psi-Segar Lansia..... 60

Bab 5 Kesehatan Mental Lansia	63
A. Konsep Kesehatan Jiwa pada Lansia	63
B. Masalah Kesehatan Mental lansia	65
C. Upaya pencegahan masalah gangguan mental lansia	68
 Bab 6 Penutup	 73
 Daftar Pustaka	 77
 Glosarium	 109
 Profil Penulis.....	 113

Bab 1

Pendahuluan

Proporsi populasi usia ≥ 60 tahun di dunia antara tahun 2015 dan 2050 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari 12% menjadi 22%. Pada tahun 2050, diprediksi bahwa 80% lansia berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2018). Indonesia termasuk negara yang memiliki struktur penduduk tua, karena persentase penduduk lanjut usia (lansia) yang telah mencapai 7,6% dari total penduduk (BPS, 2019) dan diproyeksikan akan meningkat dua kali lipat menjadi 15,77% pada tahun 2035. Peningkatan ini terjadi seiring dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia yang terus meningkat dari 69,8 tahun 2010 dan diproyeksikan menjadi 72,4 pada tahun 2035 (BKKBN, 2018). WHO (2015) menyatakan bahwa peningkatan ini memberikan dampak terhadap peningkatan pembiayaan kesehatan dan sosial sebagai akibat kerentanan dari proses menua (*ageing process*).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2017 angka harapan hidup sehat-produktif/Health Adjusted Life Expectancy (HALE) di Indonesia baru mencapai 62,7 tahun, sementara AHH pada tahun yang sama sebesar 71,5 tahun. Artinya terdapat gap atau kesenjangan sebesar 8,8 tahun di antara AHH dan HALE (Nurhayati & Widowati, 2017).

Kesenjangan ini memberikan makna bahwa bertambahnya jumlah lansia tidak disertai dengan meningkatnya produktivitas, sehingga banyak lansia memiliki ketergantungan dengan keluarga. Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan lansia dari tahun 1971 sampai 2020, menunjukkan peningkatan jumlah lansia sebesar 9,92% (sekitar 26 jutaan) dengan tingkat kemandirian secara ekonomi hanya sebesar 10,66%. Lansia yang mandiri umumnya bekerja di sektor pertanian (BPS, 2020). Dengan demikian, bertambahnya angka harapan hidup tidak disertai dengan kemandirian lansia secara ekonomi. Kondisi ini dapat menimbulkan kerentanan pada lansia terhadap kesehatannya.

Proses penuaan ditandai dengan penurunan fungsi fisiologis secara progresif dan kumulatif yang berdampak pada munculnya berbagai penyakit baik penyakit menular maupun penyakit degeneratif (Kirkwood, 2017). Selain kerentanan terhadap berbagai penyakit degeneratif, lansia juga mengalami gangguan fungsional yang ditunjukkan dengan terjadinya disabilitas (BPS, 2019). Hasil survei Riskesdas (2018) menunjukkan bahwa penyakit yang umum diderita lansia di Indonesia adalah hipertensi 63,5%, penyakit sendi 18%, masalah mulut 17%, diabetes mellitus 5,7%, penyakit jantung 4,5%, stroke 4,4%, gagal ginjal 0,8% dan kanker 0,4%. Dengan demikian, lansia perlu mendapatkan prioritas untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Penurunan kondisi fisik menyebabkan disabilitas disertai dengan munculnya masalah kesehatan mental akibat proses degeneratif yang berdampak pada penurunan kualitas hidup. Masalah kesehatan mental yang dialami lansia yaitu depresi (Miranda *et al.*, 2016); disfungsi kognitif (Pan *et al.*, 2018); ketergantungan (Yang *et al.*, 2015; de Souza

Fernandes *et al.*, 2017) serta masalah spiritual (Buco *et al.*, 2018). Kondisi ini menyebabkan lansia mengalami kerentanan baik secara fisik, mental maupun spiritual yang berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia.

Bertambahnya populasi lansia dan meningkatnya angka harapan hidup yang diikuti dengan menurunnya produktivitas dan disertai timbulnya kerentanan lansia (BPS, 2019; BPS, 2020), memerlukan upaya preventif dan promotif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan lansia yang melibatkan lansia dalam kegiatan yang akan mendorong lansia untuk berpartisipasi aktif. Salah satu bentuk partisipasi aktif lansia dalam menjaga kesehatannya adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Beberapa studi menunjukkan bahwa aktivitas fisik lansia, mampu meningkatkan ketahanan fisik dan kebugaran (Kelly *et al.*, 2014); memperbaiki kesehatan dan fungsi kognitif (Zhu *et al.*, 2016) serta mampu memperbaiki dimensi ringan (Karssemeijer *et al.*, 2017). Aktivitas fisik yang teratur memberikan efek positif terhadap kondisi fisik lansia dan perkembangan mental lansia. Aktivitas sebaya bersama dengan sesama lansia memberikan dampak positif bagi kesehatan mental lansia seperti menurunnya risiko depresi dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya (Lok *et al.*, 2017); mencegah gangguan kognitif (Middleton *et al.*, 2018); serta menurunkan dampak gangguan kesehatan seperti *alzheimer's disease*, *huntington's disease*, *multiple sclerosis*, *harkinson's disease*, *schizophrenia* and *unipolar depression* (Dauwan *et al.*, 2019). Peningkatan aktivitas fisik berkaitan dengan perubahan fungsi fisik yang lebih bugar dan mental yang sehat yang dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi lansia pada kondisi kesehatannya (Lok *et al.*, 2017).

Permasalahan yang muncul terkait partisipasi lansia dalam aktivitas fisik rendah dikarenakan aktivitas fisik hanya berfokus pada sasaran aspek fisik atau pencegahan penyakit tertentu, sehingga keberlangsungan praktik tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Keterlibatan lansia dalam kegiatan posyandu lansia menunjukkan kurangnya partisipasi, yang terlihat dari masih rendahnya cakupan lansia dalam kegiatan di posyandu serta penyelenggaraan posyandu lansia (BPS, 2020). Penyebab terbesar dalam permasalahan ini adalah keterbatasan lansia dalam mengakses pelayanan kesehatan dan masih tingginya angka morbiditas lansia (Riskesdas, 2019). Kurangnya partisipasi lansia dalam aktivitas fisik dikarenakan program aktivitas fisik lansia lebih berorientasi pada aspek fisik dan target pencegahan penyakit, sehingga kegiatan program aktivitas fisik belum ditujukan pada bagaimana mempertahankan aktivitas fisik guna memelihara kesehatan.

Program promosi kesehatan dengan pendekatan psikoedukasi dapat merubah perilaku sehat dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup lansia (Tambağ & Öz, 2013). Psikoedukasi memberikan informasi kepada lansia tentang pengelolaan penyakit dan aspek psikologis pasien (Brown *et al.*, 2011). Psikoedukasi juga memberikan pemahaman kepada lansia tentang penyakit dan cara perawatannya, latihan perilaku dalam mengatasi masalah, serta strategi mengatasi masalah perilaku lansia dalam memelihara kesehatannya (Sudja & Meirina, 2017; Andren & Elmstahl, 2005), sehingga lansia mampu memelihara kemampuan kognitif (Young *et al.*, 2017) serta mendorong norma sosial untuk mempertahankan kepatuhan lansia dalam melakukan aktivitas fisik (Burton *et al.*, 2017). Melalui psikoedukasi lansia dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi yang efektif guna membangun interaksi sosial di antara lansia sehingga menumbuhkan partisipasi sosial dalam memelihara kesehatannya secara bersama (Middleton *et al.*, 2018).

Aktivitas fisik yang teratur dengan kombinasi berbagai model memberikan efek positif pada lansia (Guiney *et al.*, 2019). Selain memberikan manfaat secara fisik, aktivitas fisik berupa senam mampu memperbaiki status mental. Studi yang dilakukan oleh Northey *et al.*, (2018) melaporkan bahwa ada perubahan fungsi kognitif yang lebih baik, namun tidak memberikan efek terhadap stres terutama pada lansia wanita yang lebih tua (Nigdelis *et al.*, 2018). Secara keseluruhan aktivitas fisik lansia dengan berbagai kombinasi intervensi mampu meningkatkan dan memelihara kesehatan lansia serta mampu meningkatkan kualitas hidup lansia di komunitas.

Aktivitas fisik yang dipimpin oleh lansia sebaya dalam mendukung aktivitas fisik yang teratur memberikan perubahan yang bermakna (Lim *et al.*, 2020). Peningkatan aktivitas fisik berkaitan dengan perubahan fungsi fisik yang lebih bugar dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi lansia dalam memandang kondisi kesehatannya. Kombinasi aktivitas mental dengan aktivitas fisik lansia memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup (Middleton *et al.*, 2018). Dukungan sosial dalam aktivitas fisik lansia sangat diperlukan terutama dari kelompok *peer group*, keluarga dan dukungan petugas kesehatan. Dukungan dalam bentuk perhatian, partisipasi dan keterlibatan lansia dalam aktivitas fisik memberikan efek terhadap kecerdasan emosional lansia (Rey *et al.*, 2019). Kecerdasan emosional yang baik akan menghasilkan kesejahteraan fisik dan psikologis, sehingga lansia mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Lansia

yang mampu melakukan aktivitasnya secara mandiri akan mampu meningkatkan kepuasan hidupnya yang akan meningkatkan kualitas hidup lansia (Şahin *et al.*, 2019; De Labra *et al.*, 2015; Justine *et al.*, 2013; Phillips *et al.*, 2013).

Aktivitas fisik lansia yang dilakukan secara teratur akan memberikan manfaat terhadap kesehatan fisik dan psikologis, sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Meskipun demikian, kegiatan aktivitas fisik lansia tidak dibarengi dengan kesadaran lansia untuk mempertahankan keberlangsungan aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik bersama yang dilakukan secara teratur hanya memberikan efek langsung terhadap kesehatan fisik, namun untuk manfaat tercapainya kesejahteraan psikologis, sosial dan spiritual, terabaikan (Ciprandi *et al.*, 2018).

Partisipasi dan keterlibatan lansia dalam aktivitas fisik seringkali menjadi penghambat dalam mencapai tingkat aktivitas yang diharapkan. Berbagai model intervensi yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan lansia dalam aktivitas fisik belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari cakupan partisipasi lansia yang terlibat aktivitas fisik bersama dalam kunjungan kegiatan senam lansia, masih rendah dan ada kecenderungan mengalami penurunan. Kondisi seperti ini memerlukan strategi intervensi yang mampu mengakomodir permasalahan aktivitas fisik lansia tersebut. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan yaitu dengan memanfaatkan kearifan lokal (*local wisdom*) dimana intervensi aktivitas fisik yang teratur (disebut sebagai senam lansia) dengan kombinasi psikoedukasi melalui pendekatan kearifan lokal diharapkan mampu mempertahankan aktivitas fisik lansia yang lebih konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Program

intervensi kombinasi antara psikoedukasi dan senam bugar lansia Indonesia dengan pendekatan kearifan lokal ini yang diberikan nama “Program Psi-Segar” (Psikoedukasi dan senam bugar lansia Indonesia).

Kearifan lokal (*local wisdom*) didefinisikan sebagai perpaduan antara pengetahuan dan tradisi yang dikhususkan untuk suatu lokasi dan diwariskan secara turun temurun (Wagiran, 2012; Musleh, 2018). Kearifan lokal juga didefinisikan sebagai seperangkat prinsip dan atau nilai-nilai yang unik pada suatu budaya atau sekelompok orang. Prinsip atau nilai yang dianut tersebut menjadi aturan universal (Muhes, 2018). Kearifan lokal merupakan perpaduan antara pengetahuan dan tradisi di suatu lokasi yang diwariskan secara turun temurun, yang mengandung prinsip atau nilai-nilai unik dari suatu budaya yang akhirnya berlaku secara universal. Dalam konteks program Psi-Segar, kearifan lokal diperlukan untuk mengembangkan nilai-nilai atau tradisi dalam mempertahankan dan meningkatkan aktivitas fisik lansia di komunitas sehingga tercapai kualitas hidup lansia yang lebih baik. Bentuk kegiatan program Psi-Segar ini terintegrasi dalam kombinasi psikoedukasi dan senam bugar lansia dengan memanfaatkan kearifan lokal di wilayah lokasi penelitian, sehingga selain secara fisik lansia sehat, juga dapat terpenuhinya kebutuhan sosialisasi lansia, kebutuhan psikologis dan lingkungan.

Hasil pencapaian kebutuhan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup lansia di komunitas. Pada umumnya, lansia melakukan aktivitas fisik tanpa disertai dengan pemahaman tentang cara melakukan kegiatan secara aman. Seiring dengan bertambahnya usia, senam memberikan manfaat yang besar bagi lansia, tetapi risiko cedera terkait dengan melakukan aktivitas fisik juga akan

semakin meningkat. Ketakutan cedera ini menyebabkan lansia enggan untuk melakukan aktivitas fisik dan tidak sedikit di antara mereka khawatir terhadap timbulnya efek negatif dari senam lansia seperti jatuh, nyeri dan cedera (Pappnk & Lange, 2011).

Pelaksanaan program aktivitas fisik lansia memerlukan pendampingan dari tenaga kesehatan terutama perawat kesehatan primer, yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan lansia di wilayah kerja puskesmas. Perawat memiliki peran secara holistik dalam menghadapi individu maupun kelompok (Robinson & Hill, 1998; Hopia *et al.*, 2004; Runciman *et al.*, 2006; Chambres & Thompson, 2009; Samarasinghe *et al.*, 2010; Povlsen & Borup, 2011) untuk melakukan strategi promosi kesehatan yang mendorong keterlibatan dan pemberdayaan individu, kelompok dan komunitas (Hopia *et al.*, 2004; Irvine, 2007; Chambres & Thompson, 2009; Samarasinghe *et al.*, 2010; Povlsen & Borup, 2011). Promosi kesehatan dilakukan dengan memberikan informasi dan pendidikan kesehatan (McDonald, 1998; Berg *et al.*, 2005; Whitehead, 2006; Irvine, 2007; Piper, 2008; Richard *et al.*, 2010; Samarasinghe *et al.*, 2010). Peran perawat komunitas merupakan pemberi pelayanan profesional dengan pendekatan holistik terhadap individu, kelompok dan komunitas.

Perawat memiliki peran penting dalam membantu lansia untuk memahami manfaat melakukan aktivitas fisik dan menumbuhkan kesadaran demi keberlangsungan kegiatan tersebut (Goodman *et al.*, 2011; Pappnk & Lange, 2011). Shuval (2017) dalam studinya menyatakan bahwa perlu untuk memberikan layanan konseling aktivitas fisik dalam perawatan primer. Perawat sebagai tenaga profesional yang berinteraksi dengan lansia, memiliki

kompetensi untuk mengembangkan kepercayaan dan membina hubungan terapeutik yang dapat membantu lansia untuk melakukan perubahan perilaku seperti meningkatkan kebiasaan melakukan aktivitas fisik yang terstruktur (Richards, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa perawat dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan upaya kesehatan pada aspek promotif dan preventif terkait keberlangsungan aktivitas fisik yang terstruktur (senam) pada lansia di komunitas (NPAP, 2015), yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup lansia.

Hasil studi terdahulu berdasarkan *data base* baik dari dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa permasalahan kualitas hidup lansia yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Studi tentang indikator kualitas hidup lansia yang tinggal di komunitas dengan yang tinggal di panti, tidak menunjukkan perbedaan yang berarti secara statistik. Perbedaan domain kualitas hidup (seperti fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan) lansia yang tinggal di komunitas lebih baik dibandingkan dengan yang tinggal di panti (Yuliati *et al.*, 2014); 2) Studi tentang kualitas hidup lansia di panti jompo di Yogyakarta dengan standar pengukuran WHOQOL-BREF melaporkan bahwa lansia yang tinggal di panti, pemenuhan aspek psikologisnya paling rendah, sedangkan pemenuhan aspek sosialnya termasuk tinggi. Hal tersebut berarti bahwa meskipun kebutuhan psikologis lansia belum terpenuhi, tetapi aspek sosialisasi di antara lansia di panti berjalan dengan baik. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa rendahnya kualitas hidup lansia dikarenakan lansia merasa terpaksa tinggal di panti, menderita tiga penyakit kronis, tidak ada sumber dukungan sosial, tidak menerima dukungan sama sekali dan persepsi tentang alasan kecukupan kebutuhan lansia tinggal di panti

(Pramesona & Taneepanichskul, 2018); 3) Studi tentang lansia yang tinggal di komunitas daerah Purworejo, Jawa Tengah melaporkan bahwa lansia perempuan *single*, tidak memiliki hubungan perkawinan, berpendidikan rendah dan status ekonomi rendah berkaitan dengan masalah kesehatan yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup lansia (Ng *et al.*, 2010). Permasalahan terkait dengan program senam lansia dalam pelayanan kesehatan yaitu: 1) intervensi aktivitas fisik lansia pada umumnya berupa kegiatan rutin senam lansia, sehingga lansia yang mengikuti senam dapat memperbaiki kesehatannya secara fisik, tetapi aspek lainnya seperti sosial, psikologis dan lingkungan belum menjadi aspek yang diperhatikan dalam memelihara dan mempertahankan kesehatan lansia. Pelaksanaan senam, hanya bisa bertahan selama program, setelahnya keikutsertaan lansia akan menurun karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya aktivitas fisik senam; 2) aktivitas fisik memerlukan dukungan dari *peer group*, sementara partisipasi dan keterlibatan lansia dalam kegiatan senam kurang optimal dikarenakan cakupan kunjungan dalam kegiatan senam lansia masih rendah dan aktivitasnya menurun seiring dengan selesainya program senam lansia, sehingga efek keberlangsungan suatu program masih belum mendapatkan perhatian; 3) bertambahnya usia lansia menyebabkan keengganan lansia dalam beraktivitas fisik karena risiko yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurang pengetahuan dan dukungan dari lingkungan terhadap manfaat aktivitas fisik pada lansia.

Bab 2

Konsep Kesehatan Lansia

A. Definisi Lansia

Lanjut usia (lansia) didefinisikan sebagai seseorang baik pria atau wanita yang telah mencapai usia di atas 60 tahun (United Nation, 2015). Batasan lansia menurut World Health Organization (WHO) meliputi: 1) Usia pertengahan (*middle age*), yaitu kelompok usia 45 sampai 59 tahun; 2) Usia lanjut (*elderly*), yaitu kelompok usia 60 sampai 74 tahun; 3) Usia lanjut tua (*old*), yaitu kelompok usia 75 sampai 90 tahun; 4) Usia sangat tua (*very old*), yaitu kelompok usia diatas 90 tahun.

Crowley (2011) mengatakan ada dua perubahan utama pada lansia menyangkut ritme sirkadian (terutama siklus tidur-bangun) dan gangguan mood (misalnya depresi). Perubahan tersebut pada umumnya dianggap sebagai peristiwa yang secara alami terjadi dalam proses menua. Jika perubahan berlangsung terus dapat mengakibatkan timbulnya kemunduran-kemunduran dan berbagai masalah kesehatan.

Proses menua memiliki efek perubahan fungsi fisik maupun mental yang meliputi perubahan fisik, perubahan mental, psikososial dan spiritual. Hal ini dapat dilihat dari

penurunan respon motorik yang menandakan lansia mengalami penurunan fisik atau penurunan kognitif pada penuaan. Bertambahnya umur lansia menyebabkan perubahan fungsi motorik yang berpengaruh terhadap penurunan fungsi skeletal (DiPietro *et al.*, 2012; Lindberg, 2010). Lansia juga mengalami kemunduran fungsi system gastrointestinal (Majumdar *et al.*, 2013). Dengan adanya pola penurunan kesehatan dan kemampuan fungsional, diharapkan lansia menjadi lebih tahan terhadap berbagai hambatan fisiologis (misalnya, infeksi), emosional (misalnya, kehilangan), atau tantangan lingkungan.

Studi di Brasil melaporkan bahwa umur yang memanjang pada lansia tidak selalu diikuti gangguan kognitif, mereka yang hidupnya tanpa gangguan kognitif memiliki harapan hidup yang lebih baik (Andrade *et al.*, 2014). Mempertahankan kesehatan fisik akan mencegah gangguan kognitif, sehingga lansia memiliki harapan hidup yang lebih baik. Seiring dengan bertambahnya usia lansia diatas 71 tahun maka terjadi penurunan kemampuan aktivitas fisik, namun demikian usia maupun pendidikan lansia dengan laju penurunan aktivitas harian total tidak berubah ketika lansia mempertahankan aktivitas motorik dasar, fungsi kognitif, aktivitas akhir hidup lainnya dan kondisi kesehatan kronis (Buchman *et al.*, 2014). Faktor sosio-demografi dan kesehatan serta orientasi positif mempengaruhi lansia untuk terus berpartisipasi dalam aktivitas fisik (Dantas *et al.*, 2017; Jin *et al.*, 2018).

Studi kohort pada lansia berusia 70 tahun melaporkan determinan status kesehatan dan memori lansia menjadi penyebab lansia mengalami kesepian (Eloranta *et al.*, 2015). Kesepian menjadi faktor pencetus depresi pada lansia (Dahlberg *et al.*, 2015), selain itu faktor psikologis lansia

seperti kepuasan hidup, kelemahan, fobia sosial, kecemasan, kerapuhan dan usia mempengaruhi masalah kesehatan lansia di masyarakat (Luchesi *et al.*, 2018). Studi lain melaporkan bahwa penyakit kronis yang diderita lansia tidak terpengaruh seiring pertambahan usia lansia (Hui, 2015).

Studi *cross-sectional* pada lansia di Korea, menemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap sukses dalam proses penuaan adalah harga diri yang diikuti oleh kepercayaan diri, hubungan interpersonal, dan *self-efficacy*. Lansia mengandalkan kepercayaan dirinya, untuk mendapatkan rasa harga diri, memperluas prestasi, dan mencapai kepuasan diri dalam kehidupan sehingga meningkat kualitas hidupnya (Cha *et al.*, 2012).

B. Proses Menua

Proses penuaan (*ageing process*) merupakan perubahan yang kompleks. Perubahan biologis yang terjadi menyebabkan akumulasi kerusakan molekuler dan seluler secara bertahap (Vasto *et al.*, 2010; Steves *et al.*, 2012). Sejalan dengan bertambahnya waktu, kerusakan menyebabkan penurunan bertahap pada mekanisme fisiologis tubuh, kerentanan terhadap penyakit serta penurunan secara keseluruhan kapasitas individu, kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan kematian (WHO, 2015). Namun demikian perubahan yang terjadi tidak konsisten pada setiap usia lanjut (lansia), pada usia tertentu pada sebagian lansia justru menikmati fungsi mental dan fisik yang baik, sementara sebagian lansia yang lain mengalami kelemahan dan memerlukan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya (Steves *et al.*, 2012). Dengan demikian, proses menua merupakan suatu mekanisme yang acak, berbeda pada setiap individu.

Perubahan yang terjadi pada lansia sebagai akibat dari proses menua meliputi perubahan fisiologis, sosial, ekonomi serta psikologis, yang berdampak pada kerentanan terhadap penyakit, penurunan fungsi fisik sehingga memerlukan perawatan suportif, mempertahankan kualitas hidup yang memuaskan dalam menghadapi meningkatnya kecacatan, beradaptasi, dan merenungkan kematian (Mauk, 2014). Perbedaan faktor budaya, spiritual, regional, sosial ekonomi, pendidikan, dan lingkungan serta persepsi dampak status kesehatan lansia dan pilihan tentang kebutuhan kesehatan akan mempengaruhi lansia menghadapi proses menua yang sehat (Dziechciaz & Filip, 2014).

Umur lansia yang mengalami peningkatan dihadapkan pada permasalahan dalam memahami emosi dan kondisi mental terutama pada masa dewasa akhir (Henry *et al.*, 2013). Bertambahnya usia harapan hidup lansia hanya berkorelasi pada perubahan kognitif, tidak mempengaruhi perubahan afektifnya (Bottiroli *et al.*, 2015).

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang umumnya terjadi dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa, dan tua (Nugroho, 2012).

Fungsi fisiologis menurun seiring dengan proses penuaan, yang mungkin disebabkan oleh faktor biologis, faktor sosial dan gaya hidup yang menyertai lansia. Bukti menunjukkan, bahwa ada heterogenitas substansial dalam pola penuaan (Rowe and Kahn, 1997). Pola penurunan kesehatan dan kemampuan fungsional, diharapkan lansia menjadi lebih tahan terhadap berbagai hambatan fisiologis

(misalnya, infeksi), emosional (misalnya, kehilangan), atau tantangan lingkungan (DiPietro *et al.*, 2012).

C. Kualitas Hidup Lansia

Pertumbuhan populasi lanjut usia dan meningkatnya masalah kesehatan lansia yang berdampak pada penurunan kualitas hidup, tentunya memerlukan intervensi kesehatan untuk mengurangi masalah kesehatan terkait usia lanjut, baik secara preventif (mencegah timbulnya penyakit atau penyulit yang berhubungan dengan kurang gerak), kuratif (dapat memberikan alternatif bahwa *exercise* sebagai upaya penyembuhan penyakit), rehabilitatif (diharapkan dapat membantu pemulihan gangguan fungsi tubuh akibat penyakit dan kecacatan) dan promotif (untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan daya tahan tubuh) (Kementerian Kesehatan, 2013).

Untuk itu dibutuhkan adanya program layanan yang berfokus pada upaya pencegahan (preventif) dan treatment (kuratif) bagi populasi kelompok lansia, berupa senam lansia yang diperkuat dengan psikoedukasi.

1. Pengertian Kualitas Hidup

Kualitas hidup didefinisikan sebagai sebuah konsep multidimensional yang luas mencakup evaluasi subjektif dari aspek positif dan negatif dalam kehidupan (Orley *et al.*, 1998), termasuk beberapa domain kehidupan seperti pekerjaan, perumahan, dan kesehatan (Zubritsky *et al.*, 2012). Kualitas hidup cenderung berkaitan dengan kepuasan hidup. Kualitas hidup bersifat dinamis yang dipengaruhi masalah kesehatan fisik, status kesehatan, tingkat kemandirian, hubungan sosial, keyakinan dan keterkaitannya dengan lingkungan yang menonjol saat ini (WHOQOL, 1997).

Berdasarkan definisi kesehatan WHO dari tahun 1948, yang merupakan salah satu pernyataan pertama yang mengakui pentingnya tiga dimensi dalam kualitas hidup (yaitu, fisik, mental dan sosial) dalam konteks penyakit, maka *The World Health Organization quality of life assessment Group* (WHOQOL Group, 1997) mendefinisikan kualitas hidup adalah: "Persepsi individu tentang posisinya dalam kehidupan yang mengarah pada konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka hidup dan berkaitan dengan tujuan, harapan, standar, dan kekhawatiran individu. Konsep luas yang dipengaruhi secara kompleks oleh kesehatan fisik individu, keadaan psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, kepercayaan pribadi, dan hubungannya dengan fitur yang menonjol di lingkungannya.

Birren *et al.* (2014) menyatakan bahwa definisi kualitas hidup mengandung aspek fisik, psikologis, relasi sosial dan lingkungan bersifat dinamis yang saling terkait satu sama lain sebagai tanggapan terhadap peristiwa kehidupan dan kesehatan serta pengalaman menghadapi situasi positif maupun negatif.

Farquhar (1995) mengklasifikasikan definisi kualitas hidup menjadi dua, yaitu *expert definition* (definisi ahli) dan *lay definition* (definisi awam). Definisi ahli terdiri dari tipe definisi global, definisi komponen dan definisi fokus. Definisi global bersifat umum, contohnya Abrams (1973) mendefinisikan kualitas hidup sebagai derajat kepuasan yang dirasakan seseorang terhadap berbagai aspek kehidupannya. Definisi komponen mengacu pada sifat multidimensi dari kualitas hidup seperti aspek otonomi pribadi, kepuasan, kesejahteraan fisik dan mental, status sosio-ekonomi, kualitas lingkungan, aktivitas dan faktor

budaya. Sedangkan definisi fokus hanya terpusat pada satu atau dua dimensi, misalnya suatu penelitian yang berfokus pada pelayanan medis maka kualitas hidup akan terpusat pada aspek kesehatan (*cit.* Bond & Corner, 2004).

Beberapa tahun terakhir ini muncul anggapan bahwa definisi awam dipandang lebih tepat dibandingkan dengan definisi ahli. Berkembang dari gerontologi yang menekankan bahwa kualitas hidup tidak hanya dilihat dari pernyataan subjektif individu tetapi juga didapat dari pernyataan orang terdekat lansia. Rapley (2003) menjelaskan definisi kualitas hidup seseorang bergantung pada populasi tertentu karena aspek kehidupan yang melambangkan kualitas kehidupan berbeda antara individu satu dengan yang lain. Kualitas hidup yang rendah pada lansia merupakan akibat dari berbagai penyakit degeneratif yang berdampak pada menurunnya produktivitas di usia lanjut, karena lansia tidak dapat menjalankan aktivitas hidup sehari-hari secara normal, baik dari segi fisik, kejiwaan atau mental, sosial maupun spiritual, penurunan kapasitas mental, perubahan peran sosial, kepikunan, serta depresi. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dimaknai bahwa kualitas hidup lansia yang terkait dengan unsur kesehatan merupakan perasaan subjektif tentang berbagai kondisi lansia tersebut secara menyeluruh.

2. Dimensi Kualitas Hidup

Kualitas hidup dapat dipandang dari aspek fisik, psikologis, sosial dan lingkungan serta kemampuan lansia dalam mengelola dan menjalani kehidupannya. Kualitas hidup lansia memiliki dua dimensi, yaitu objektif dan subjektif. Dimensi objektif terdiri dari standar hidup,

pendapatan, pendidikan, status kesehatan, umur panjang dan yang terpenting adalah cara individu dapat mengontrol dan sadar mengarahkan hidupnya, sedangkan dimensi subjektif didasarkan pada respon psikologis individu terhadap kepuasan dan kebahagiaan hidup (Netuveli & Blane, 2008), fisik, sosial dan lingkungan (Halvorsrud, 2010). Kualitas hidup lansia diperoleh jika lansia memiliki rasa penerimaan dan kepuasan terhadap kehidupannya melalui penyesuaian terhadap unsur-unsur penting dalam kehidupan sehingga membantu lansia berhasil menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan situasi (Dahlan, Ibrahim & Anwar, 2014). Dengan demikian kualitas hidup subjektif adalah sebagai persepsi individu tentang cara hidup yang baik dirasakan oleh setiap individu yang memilikinya.

Gill *et al.*, (2013) mengemukakan tentang kualitas hidup lansia yang terintegratif pada aktivitas fisik yang terdiri dari kesejahteraan sosial, kesejahteraan fisik, kesejahteraan emosional, kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan kognitif. Kesejahteraan fisik adalah komponen kunci. Penelitian yang dilakukan oleh McAuley & Elavsky (2006) dan Lox *et al.* (2010), memberi konfirmasi hubungan logis antara aktivitas fisik dan persepsi kesehatan fisik. Penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan fisik fungsional, atau kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari, dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan berhubungan dengan kualitas hidup untuk orang lanjut usia, sedangkan Gill *et al.*, (2013) menyatakan model awal membagi domain kesejahteraan fisik menjadi tiga bagian yaitu kesehatan fisik, kebugaran, dan fungsi fisik.

Program latihan fisik berbasis masyarakat menawarkan berbagai jenis latihan bagi lansia dengan berbagai tingkat kemampuan fungsional yang memiliki manfaat fisik dan psikososial. Program ini dapat bermanfaat dalam memelihara dan meningkatkan kebugaran dan kemandirian lansia (Mason, *et al.*, 2016).

Studi tentang aktivitas fisik wanita lanjut usia berhubungan positif terhadap tingkat kebugaran kardiorespirasi dan berkorelasi negatif terhadap aktivitas fisik yang kuat dengan fungsi sosial (Ciprandi *et al.*, 2018). Kebugaran yang tumbuh sebagai akibat aktivitas fisik akan meningkatkan kualitas hidup lansia (Feldman & Kubota, 2015).

Berikut ini diuraikan tentang dimensi atau domain yang mempengaruhi kualitas hidup lansia, antara lain terdiri dari:

a. Kesehatan fisik

Faktor kesehatan fisik berasal dari internal tubuh lansia yang ditunjukkan dengan baiknya sistem dan fungsi tubuh, kondisi organ tubuh secara keseluruhan. Kesehatan fisik akan membantu individu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik lansia juga memberikan kontribusi positif terhadap mencegah penyakit kronis, menurunkan biaya perawatan, meningkatkan kemampuan kognitif lansia, peningkatan fungsi otot, penurunan rasa takut jatuh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia (Svantesson *et al.*, 2015). Durasi partisipasi yang lebih lama dalam program aktivitas fisik berbasis komunitas, mampu berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik untuk lansia (Da Fonte *et al.*, 2016). Selain itu ada studi yang melaporkan hubungan

kausatif antara program latihan fisik lansia secara teratur memberikan efek terhadap penurunan depresi, peningkatan kualitas hidup dan harga diri (Park *et al.*, 2014). Kualitas hidup lansia dapat dicapai dengan berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas fisik secara teratur dengan meminimalkan nyeri, fungsi fisik lebih baik serta dapat memerankan fungsi sosial dalam aktivitas fisik (Acree *et al.*, 2006). Aktivitas fisik lansia berkaitan secara positif dan konsisten terkait dengan kualitas hidup lansia (Vagetti *et al.*, 2014).

Kesejahteraan fisik lansia terindikasikan dari kemampuan lansia untuk beraktivitas terbebas dari nyeri, fungsi fisik lebih baik, bebas dari keterbatasan serta dapat memerankan fungsi sosial dalam beraktivitas fisik (Acree *et al.*, 2006; Withall *et al.*, 2014). Aktivitas fisik berhubungan dengan kualitas hidup lansia terutama berkaitan dengan kondisi kesehatannya (Halaweh *et al.*, 2015). Dengan mempertahankan aktivitas fisik yang teratur dan terukur maka akan membantu lansia meningkatkan kesehatan baik fisik maupun mental (Puciato *et al.*, 2018).

Partisipasi lansia dalam beraktivitas fisik seperti berjalan menentukan kualitas hidupnya, oleh karena itu berjalan akan membantu pengobatan penyakit lansia atau menurunkan risiko kecacatan. Kondisi kesehatan tersebut mendorong peningkatan kualitas hidup lansia (Clifford *et al.*, 2014). Untuk mengetahui kualitas hidup lansia yang membaik dapat dilihat dari domain fisik, yaitu: kapasitas fungsional; kualitas hidup umum; otonomi; aktivitas masa lalu, sekarang dan masa depan; keintiman; kesehatan mental; daya

ingat; dan psikologis (Vagetti *et al.*, 2014; Bullo *et al.*, 2015).

Kesehatan fisik lansia sebagai dampak dari aktivitas secara rutin memberikan pengaruh terhadap kebugaran fisik dan ketahanan fisik yang membantu meningkatkan fungsi kognitif lansia (Lee *et al.*, 2015; Lindwall *et al.*, 2012). Peningkatan fungsi kognitif dapat meningkatkan kualitas hidup lansia yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari berbagai penyakit kronik yang diderita lansia saat ini (Chae *et al.*, 2020). Selain aktivitas fisik, ketahanan fungsi aktivitas fisik diperoleh dengan menambahkan aktivitas latihan yang membantu meningkatkan kekuatan otot pada tungkai bawah pada orang tua dengan gejala kelemahan (Nagai *et al.*, 2018). Ketahanan aktivitas fisik juga memberikan efek pada vitalitas lansia (Olsson *et al.*, 2014; Ryan *et al.*, 2010), yang dapat memberikan makna hidup dan mencegah lansia memiliki perasaan tidak berarti (Ju, 2017), depresi memberikan makna pada kualitas hidup lansia (Frankl, 2017).

Kondisi kesehatan fisik yang optimal pada lansia mendorong terbentuknya ikatan sosial diantara sesama lansia yang dapat membantu dalam memelihara kepatuhan dan peningkatan aktivitas fisik (Fu *et al.*, 2018); menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian mendorong lansia mempertahankan aktivitas fisik (Mosallanezhad *et al.*, 2017) serta membangun dukungan sosial diantara sesama lansia (Jansons *et al.*, 2018). Kesehatan fisik memungkinkan lansia dapat aktivitas fisik seperti berjalan maupun

bersepeda dengan nyaman sehingga terjalin interaksi sosial (Duan *et al.*, 2018).

b. Hubungan sosial

Relasi sosial merupakan faktor eksternal yaitu individu berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Interaksi sosial akan membantu lansia meningkatkan perannya di masyarakat sehingga meningkatkan kepuasan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Secara luas, diketahui bahwa partisipasi dalam aktivitas fisik telah efek positif yang signifikan pada peningkatan dan pemeliharaan kesehatan mental, mencegah dan meminimalkan efek kronis penyakit, serta meningkatkan kesehatan dan fungsi fisik pada lansia (Liffiton *et al.*, 2012).

Lansia yang tinggal di masyarakat memiliki kualitas hidup dan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di institusi atau rumah jompo (Ramocha *et al.*, 2017); bahkan lansia tersebut mungkin akan mengalami, memiliki keterbatasan fungsional yang lebih tinggi dibandingkan dengan lansia dalam kondisi kronis yang dilibatkan dengan aktivitas sosial (Meisner *et al.*, 2010). Partisipasi sosial (seperti jaringan sosial, partisipasi sosial informal, sukarelawan) berkontribusi pada hubungan antara partisipasi sosial dan kesehatan melalui mekanisme dukungan sosial dan kohesi sosial bersama dengan komunitas yang lebih luas (Douglas *et al.*, 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik berkaitan erat dengan keterlibatan atau relasi sosial.

Keterlibatan lansia dalam aktivitas fisik melalui jaringan sosial, berteman dengan lansia yang

memiliki jaringan yang luas, suka bersosialisasi mendorong lansia aktif dalam kegiatan aktivitas fisik (Ho *et al.*, 2018). Studi *systematic review* melaporkan bahwa lansia yang lebih tua menganggap aktivitas fisik tidak diperlukan karena berpotensi membahayakan, sementara lansia lainnya mengakui manfaat dari aktivitas fisik, namun merasa mengalami hambatan dalam beraktivitas.

Upaya meningkatkan partisipasi aktivitas fisik pada lansia diperlukan strategi untuk: (1) meningkatkan kesadaran akan manfaat dan meminimalkan risiko yang dirasakan lansia dalam beraktivitas secara fisik dan (2) meningkatkan akses terhadap lingkungan dan keuangan (Franco *et al.*, 2015). Studi yang dilakukan oleh Queiroz *et al.*, (2016) melaporkan bahwa lansia yang melakukan aktivitas secara rutin didorong oleh fungsi mental dan sosial yang tinggi sehingga mempengaruhi kualitas hidup lansia

Aktivitas fisik teratur lansia selain mendapatkan manfaat fisik yang lebih baik, juga dapat mendorong lansia melakukan sosialisasi diantara sesama lansia sehingga memungkinkan lansia membangun komunitas sesama lansia (Mašanovic *et al.*, 2019). Kemampuan sosialisasi diperlukan oleh lansia untuk mencegah lansia mengisolasi diri dan *sedentary* (Popovic & Masanovic, 2019). Kedua kondisi ini memberikan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik maupun psikologis.

Hubungan sosial bagi lansia sangat penting untuk membangun partisipasi lansia dan keterlibatan lansia dalam aktivitas fisik yang teratur (Fu *et al.*,

2018). Keterlibatan lansia mendorong partisipasi bagi lansia lain dan memberikan kontribusi bagi keberlangsungan aktivitas fisik. Dukungan sosial dari keluarga membantu lansia mendapatkan modal sosial yang baik (Newsom *et al.*, 2018).

c. Kesehatan psikologis

Kesehatan psikologis merupakan kondisi internal individu yang menekankan pada aspek psikis yang sifatnya subjektif, yang menggambarkan persepsi terhadap diri dan kehidupannya, kemampuan kognitif, persepsi terhadap diri dan perasaannya. Kesehatan psikologis berkaitan juga dengan kesejahteraan. Beberapa studi menyatakan keterkaitan antara kesejahteraan subjektif dan kesehatan terkait erat dengan usia. Tiga aspek kesejahteraan subjektif dapat dibedakan menjadi kesejahteraan evaluatif (atau kepuasan hidup), kesejahteraan hedonis (perasaan bahagia, kesedihan, kemarahan, stres, dan rasa sakit), dan kesejahteraan *eudemonic* (rasa tujuan dan makna dalam hidup) (Steptoe *et al.*, 2015). Berdasarkan studi tentang keterkaitan antara kesejahteraan psikologis dengan kesehatan, dilaporkan oleh Kim *et al.*, (2016) bahwa pemanfaatan waktu luang lansia yang digunakan untuk aktivitas fisik ternyata mampu memberikan manfaat psikologis seperti pengaruh positif, optimisme, kesejahteraan psikologis, dan kualitas hidup.

Aktivitas fisik pada lansia memberikan kesejahteraan psikologis yang lebih baik dan dapat menghindarkan lansia dari gejala depresi dan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia (Lok *et al.*, 2017).

Aktivitas fisik lansia juga mampu mencegah masalah kesehatan mental seperti stress, kecemasan dan depresi, karena aktivitas fisik memberikan penguatan keadaan yang positif seperti kesejahteraan dan suasana hati yang baik (Parra-Rizo, 2018; de Oliveira *et al.*, 2019; Antunes *et al.*, 2020). Bentuk aktivitas fisik ini berupa aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan fisik, kemampuan fungsional, keseimbangan sehingga dapat mengurangi depresi dan kecemasan (Chang *et al.*, 2019).

Aktivitas fisik lansia secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan mental terutama kualitas tidur, sehingga aktivitas fisik berkaitan erat dengan kualitas hidup lansia (Yuan *et al.*, 2020); dan mampu memperbaiki kondisi psikofisik lansia perempuan (Battaglia *et al.*, 2016). Aktivitas fisik secara positif dikaitkan dengan kesejahteraan psikologis yang positif meskipun terdapat nyeri, keterbatasan fungsional dan pembatasan fisik dan dipengaruhi budaya dimana lansia berada (Lee & Howard, 2019). Aktivitas fisik memberikan tekanan psikologis untuk mendorong lansia beraktivitas secara teratur guna mencapai kebugaran dan kesejahteraan (Gyasi, 2019), sehingga dalam melaksanakan aktivitas fisik tekanan psikologis dijadikan modal untuk keterlibatan dan partisipasi lansia yang lebih baik (Owari *et al.*, 2018).

Aktivitas fisik yang teratur, efektif meningkatkan kesehatan mental secara umum melalui perbaikan suasana hati, persepsi diri dan meningkatkan fungsi kognitif pada lansia seiring dengan penambahan usia lansia (Fox, 1999). Aktivitas fisik juga memberikan efek terhadap kesehatan fisik

yang mendorong tumbuhnya kesejahteraan mental bagi lansia yang melakukan aktivitas fisik secara rutin dan teratur (Penedo & Dahn, 2005). Studi meta analisis melaporkan efek tiga kali lipat lebih besar pada subjek yang dilakukan intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Efek terkuat pada *self efficacy*, peningkatan status kardiovaskuler, kekuatan dan kapasitas fungsional, studi ini mengaitkan kondisi ini dengan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan dan kesejahteraan mental lansia yang baik yang mendukung kualitas hidup lansia (Gill *et al.*, 2013; Queiroz *et al.*, 2016).

Program aktivitas fisik bagi lansia yang menetap (*sedentary*), selama 24 minggu dengan intensitas sedang dibandingkan dengan program pendidikan kesehatan selama periode waktu tersebut memberikan perbaikan dalam fungsi kognitif secara umum maupun domain spesifik lainnya (Sink *et al.*, 2015). Studi lain di Skandinavia melaporkan bahwa adanya perubahan kognitif dan sosial juga memberikan keuntungan dalam fungsi kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Ada peningkatan keseimbangan tubuh setelah tiga bulan periode intervensi aktivitas fisik yang terawasi, tetapi jika tanpa aktivitas yang terawasi maka transfer kemampuan semakin memburuk (Frändin *et al.*, 2016). Studi longitudinal melaporkan aktivitas fisik lansia dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkontribusi positif terhadap kemampuan kognitif lansia (Allerhand *et al.*, 2014). Studi *randomized control trial* (RCT) melaporkan adanya ketebalan kortikal di area frontal dan volume hipocampus pada

lansia yang melakukan latihan fisik aerobik. Hal ini menunjukkan bahwa latihan aerobik memiliki potensi untuk meningkatkan kognisi dan mengurangi atrofi otak pada lansia (Jonasson *et al.*, 2017).

Spiritualitas dalam aktivitas fisik lansia memberikan efek yang menguntungkan dalam menumbuhkan kesejahteraan di antara lansia. Lansia dengan spiritualitas tinggi mampu mengelola kesejahteraan mereka dengan lebih baik (Saleem & Sajid, 2015). Studi lain menunjukkan bahwa adanya lansia yang lebih spiritual dan aktif dalam beraktivitas fisik akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan dimediasi oleh persepsi efikasi diri (Konopack & McAuley, 2012).

d. Kondisi lingkungan

Keadaan lingkungan yang menggambarkan kondisi lingkungan lansia saat ini, status sosiodemografi, kondisi alam, ekonomi dan budaya. Lingkungan yang kondusif bagi lansia adalah yang membantunya untuk melakukan aktivitas aman dan nyaman sehingga memberikan perasaan positif bagi lansia sehingga mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Temuan saat ini menunjukkan hubungan yang sinergis antara jarak taman dan kepercayaan sosial untuk berjalan kaki pada orang lanjut usia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap hubungan kompleks antara taman, aktivitas fisik, rekreasi dan konteks sosial lingkungan (Cauwenberg, *et al.*, 2015).

Lingkungan yang nyaman dan terbuka serta mudah diakses lansia mendorong lansia berpartisipasi dalam aktivitas fisik lebih baik (Link *et*

al., 2020). Kondisi lingkungan yang telah disesuaikan dengan keamanan dan kenyamanan bagi lansia, membantu lansia untuk mempertahankan aktivitas fisik dan menurunkan kekhawatiran akan cedera akibat lingkungan yang tidak aman. Pengkondisian lingkungan membantu lansia beraktivitas bersama dan mendukung lansia bersosialisasi.

3. Determinan kualitas hidup lansia

Determinan atau faktor penentu kualitas hidup lansia merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia di komunitas. Faktor tersebut adalah:

a. Sosio-demografi

Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia adalah faktor sosio-demografi. Faktor sosiodemografi terdiri dari faktor sosio-ekonomi (yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan dan penghasilan) dan faktor demografi lansia (yang terdiri dari usia, jenis kelamin, agama dan status perkawinan).

Lansia yang memiliki pendidikan dan pekerjaan yang baik memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Indrayani & Ronoatmodjo (2018). Hal ini dikarenakan pendidikan dan pekerjaan dapat menentukan status sosial sehingga kebutuhan akan kesehatannya lebih baik. Kesehatan yang baik yang dimiliki lansia secara signifikan berhubungan dengan kualitas hidup lansia (Jariah & Kusbaryanto, 2019). Pendidikan lansia yang tinggi memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan lansia dengan pendidikan yang lebih rendah.

Pengetahuan yang baik mampu mendorong lansia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan

kelompok dalam program aktivitas fisik dan mampu mendorong untuk patuh mengikuti program serta sangat efektif dalam mempromosikan pelibatan lansia dalam kegiatan tersebut (Burton *et al.*, 2017). Pendidikan lansia yang tinggi juga mampu mendorong lingkungannya berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan memperbaiki kesehatan mentalnya (Tomioka *et al.*, 2017).

Studi lain melaporkan bahwa pendidikan tinggi pada lansia berkaitan dengan kualitas hidup dan fungsi kognitif yang lebih baik (Harithasan *et al.*, 2020), sehingga dapat mendorong keterlibatan lansia lain dalam mendukung aktivitas bersama dan mempengaruhi perubahan lingkungannya (Aartolahti *et al.*, 2015). Partisipasi dan keterlibatan aktif lansia mendorong terbentuknya ikatan sosial, dan dapat membangun kontrol sosial di kelompok guna memelihara kepatuhan dan peningkatan aktivitas fisik (Fu *et al.*, 2018).

Pendidikan dan pekerjaan lansia juga berkaitan dengan status sosial ekonomi, kepercayaan diri dan kemandirian lansia dalam melibatkan diri dalam mempertahankan aktivitas fisik di komunitas (Mosallanezhad *et al.*, 2017). Selain itu, status sosial juga mampu menjadi faktor penentu dalam memelihara kesehatan lansia (Arrospide *et al.*, 2019).

b. Dukungan sosial

Dukungan sosial keluarga membantu lansia untuk mempertahankan dan memelihara kesehatannya baik fisik maupun psikologisnya. Peran keluarga sangat penting dalam membantu lansia dalam melakukan aktivitas fisik serta keterlibatan

dalam sosialisasi dengan lingkungannya. Lansia yang mendapatkan dukungan sosial keluarga dapat menjadi agen kesehatan bagi lansia lainnya (Wu and Sheng, 2019). Dengan demikian, dukungan sosial keluarga membantu lansia mampu meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik (Şahin *et al.*, 2019). Lansia yang telah mendapatkan dukungan sosial baik dari keluarga maupun dari teman sebaya dapat memelihara kecerdasan emosional (Rey *et al.*, 2019). Kecerdasan emosional mendorong lansia mencapai kesejahteraan fisik dan psikologis sehingga dapat mempertahankan kesehatannya secara mandiri, sehingga pencapaian kualitas hidup seiring dengan perkembangan waktu, mampu meningkatkan kualitas hidup lansia (Justine *et al.*, 2013; de Labra *et al.*, 2015; Phillips *et al.*, 2013). Kecerdasan emosional juga dapat dijadikan indikator bagi kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis lansia (Tomioka *et al.*, 2017). Pencapaian kondisi seperti ini membantu lansia mencapai derajat kualitas hidup lansia menjadi lebih baik (Meneghini *et al.*, 2016).

Dukungan sosial diperlukan lansia guna mencegah perasaan kesepian terutama saat menjalin hubungan dengan sesama lansia lainnya, anggota keluarga dan orang disekitarnya dan *sedentary*. Lansia yang mampu menghindari kondisi kesepian membantu meningkatkan kepuasan hidup (Bai *et al.*, 2018). Sementara itu, penyebab lansia mengalami kesepian adalah status perkawinan. Status perkawinan membantu lansia mengakses orang terdekat yang membantu lansia berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam melakukan aktivitas fisik bersama (Syed *et al.*, 2017).

c. Status kesehatan lansia

Status kesehatan lansia merupakan kondisi kesehatan lansia yang berkaitan dengan indeks massa tubuh (IMT), status mental kognitif lansia (*mini mental status examination* atau MMSE), level aktivitas fisik (*physical activity scale for the elderly* atau PASE). Hasil beberapa studi melaporkan tentang kondisi kesehatan lansia saat ini meliputi:

1) Indeks massa tubuh (IMT).

Indeks massa tubuh merupakan indikator berat badan lansia. Lansia yang memiliki berat badan berlebihan jika dikaitkan dengan kondisi kesehatannya, maka kualitas hidup lansia akan rendah (Yan *et al*, 2004; You *et al.*, 2018). Studi lain mengatakan, kualitas hidup lansia dipengaruhi kelebihan berat badan terutama pada aspek psikologis lansia dan lingkungan (Kusumaratna & Hidayat, 2016).

Kelebihan berat badan akan mempengaruhi kualitas hidup lansia di komunitas. Kelebihan berat badan menyebabkan risiko tinggi terkena osteoarthritis, diabetes, dan kecacatan (Kalish, 2016); penyakit kronis (Meneghini *et al.*, 2016); hipertensi dan gangguan kognitif (Rambod, Ghodsbin & Moradi, 2020). Selain masalah kesehatan fisik, kelebihan berat badan juga memberikan dampak pada kesehatan mental dan emosional (Renzaho, Wooden & Houng, 2010; Bann *et al.*, 2015; Chang *et al.*, 2019; Lærum-Onsager *et al.*, 2020).

Kelebihan berat badan antara laki-laki dengan perempuan memberikan dampak yang berbeda (Meneghini *et al.*, 2016). Kelebihan berat badan pada

lansia wanita memiliki keterkaitan dengan kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan lansia dengan berat badan normal (Moon, 2017). Studi lain melaporkan bahwa lansia laki-laki dengan kelebihan berat badan memiliki kualitas hidup yang lebih buruk dibandingkan dengan lansia perempuan terutama aspek psikologis dan lingkungan (Kusumaratna & Hidayat, 2016). Akibatnya lansia memiliki keterbatasan pada hidup mandiri, gangguan dalam hubungan sosial serta keterbatasan aktivitas fisik yang menstimulasi pengalaman nyeri akibat bergerak.

2) Status mental kognitif lansia (MMSE)

Kondisi status mental kognitif lansia berkaitan dengan kualitas hidup lansia. Lansia dengan kondisi gangguan status mental kognitif umumnya mengalami kesulitan untuk membina hubungan baik dengan orang lain dikarenakan kesulitan memahami inti pembicaraan lawan bicara, sehingga lansia dengan gangguan mental kognitif berhubungan dengan kualitas hidup lansia (Chae *et al.*, 2020). Keterkaitan ini dapat dilihat dari studi lain, yaitu lansia yang mengalami gangguan pendengaran berkaitan dengan gangguan kognitif yang mempengaruhi kualitas hidup lansia di komunitas menjadi kurang baik (Harithasan *et al.*, 2020).

Aktivitas yang dilakukan rutin secara berkelanjutan memberikan ketahanan dalam beraktivitas fisik yang membantu meningkatkan fungsi kognitif lansia (Lee *et al.*, 2015; Lindwall *et al.*, 2012). Chae *et al.* (2020), menyatakan bahwa peningkatan fungsi kognitif berhubungan dengan

kualitas hidup lansia. Umumnya lansia laki-laki dengan gangguan kognitif diikuti perasaan kesepian, tertekan, dan memiliki pikiran untuk bunuh diri lebih sering daripada wanita. Kondisi ini terjadi jika lansia tinggal sendirian (Ko *et al.*, 2019). Seringkali kondisi lansia yang demikian ini, dialami oleh lansia dengan pendidikan dan status sosial ekonomi yang rendah (Kim *et al.*, 2019).

3) Level aktivitas fisik (PASE)

Level aktivitas fisik menentukan ketahanan fungsi aktivitas fisik membantu meningkatkan kekuatan otot pada tungkai bawah lansia dengan gejala kelemahan (Nagai *et al.*, 2018). Ketahanan aktivitas fisik juga memberikan efek pada vitalitas lansia (Olsson *et al.*, 2014; Ryan *et al.*, 2010), yang memberikan makna pada kualitas hidup lansia (Ju, 2017). Kemaknaan hidup membantu lansia terhindar mengalami depresi, dan perasaan tidak berarti (Frankl, 2017).

Aktivitas fisik lansia selain memberikan perbaikan kondisi fisik juga mendorong terbentuknya ikatan sosial membantu dalam memelihara kepatuhan dan peningkatan aktivitas fisik (Fu *et al.*, 2018); menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian mendorong lansia mempertahankan aktivitas fisik (Mosallanezhad *et al.*, 2017). Aktivitas fisik juga membangun dukungan diantara sesama lansia (Jansons *et al.*, 2018). Selain itu, diperlukan lingkungan yang mendukung terjadinya interaksi sosial terkait lokasi yang memungkinkan lansia dapat berjalan maupun bersepeda dengan nyaman (Duan *et al.*, 2018).

4) Intensi atau niat

Intensi (*Intention*) atau niat mencerminkan motivasi dan kemauan seseorang untuk terlibat dalam suatu kegiatan/perilaku (Ajzen, 1991; Hagger & Chatzisarantis, 2005) yang merupakan penentu utama perilaku individu (Vallance *et al.*, 2011; Kosma, 2012), dan yang akan membentuk serta mengarahkan perilaku seseorang. Selain itu, Gourlan *et al.* (2016), mengatakan bahwa *intention* merupakan upaya lansia dalam keterlibatan untuk memelihara kondisi kesehatannya dan aktif dalam berbagai kegiatan di masa tua.

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa niat berhubungan dengan kualitas hidup lansia. Niat mendukung keikutsertaan program aktivitas fisik lansia di komunitas. Aktivitas fisik mendukung perbaikan kesehatan lansia yang berkaitan dengan kualitas hidup lansia (Vahedian-Shahroodi *et al.*, 2019). Intervensi yang mampu membangun pemberdayaan kesehatan lansia dalam berkeaktifitas fisik, maka akan meningkatkan niat untuk beraktivitas fisik (Caillouet & Cosio-Lima, 2019). Niat pemeliharaan atau penambahan berat badan lebih direkomendasikan dalam aktivitas fisik lansia daripada penurunan berat badan. Niat ini berhasil meningkatkan kesehatan yang berhubungan dengan kualitas hidup lansia (So, 2019). Dengan demikian intervensi pemberdayaan kesehatan maupun pemeliharaan berat badan berkaitan dengan kualitas hidup lansia di komunitas sangat dibutuhkan.

Bab 3

Psikoedukasi Lansia

A. Pengertian psikoedukasi

Istilah psikoedukasi pertama kali digunakan oleh Anderson *et al.* (1980), untuk menggambarkan konsep terapi perilaku yang melibatkan pasien dan keluarga tentang penyakit pasien, pelatihan pemecahan masalah, pelatihan komunikasi dan ketegasan diri. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Grawe *et al.* (2004), yang mengemukakan bahwa psikoterapi terdiri dari interaksi terapeutik, klarifikasi (atribut kausal) dan peningkatan kompetensi diri. Keefektifan terapi tersebut didukung oleh Pitschel-Walz & Bäuml (2007), dengan model intervensi *supportive therapy* (ST) dan *cognitive behavioral therapy* (CBT).

Psikoedukasi adalah pendidikan psikologis, yang pada umumnya disebut sebagai pendidikan pribadi atau sosial, sehingga individu dan keluarga dapat mengatasi dan mencegah terjadinya gangguan emosional dengan menggunakan strategi koping yang efektif (Supratiknya, 2011). Menurut Brown (2011), psikoedukasi adalah proses memberikan informasi penting yang terkait dengan permasalahan individu dengan melihat potensi ancaman dan mengajarkan ketrampilan dalam strategi koping individu agar dapat beradaptasi terhadap berbagai situasi krisis

kehidupannya. Psikoedukasi dapat diterapkan pada berbagai kelompok usia dan dengan berbagai tingkat pendidikan.

Psikoedukasi merupakan intervensi sistematis, terstruktur, didaktik, tentang penyakit dan perawatannya, dan termasuk mengintegrasikan aspek emosional dan motivasi yang memungkinkan pasien serta anggota keluarga untuk mengatasi penyakitnya, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan kemanjurannya atau *efficacy* (Bäumli *et al.*, 2006; Ekhtiari, Rezapour, Aupperle & Paulus, 2017).

Psikoedukasi juga diartikan sebagai suatu proses mengajarkan klien dengan penyakit mental dan anggota keluarga tentang sifat penyakit termasuk etiologi, perkembangan, konsekuensi, prognosis, pengobatan dengan berbagai alternatifnya (Barker, 2003). Selain itu, psikoedukasi juga dimaknai sebagai pelatihan pemberdayaan pasien yang ditargetkan untuk meningkatkan kesadaran dan proaktif, menyediakan alat untuk mengelola, koping dan hidup dengan kondisi kronis (yaitu peningkatan kepatuhan, identifikasi deteksi dini, gaya hidup, manajemen krisis, komunikasi), dan mengubah perilaku dan sikap yang berkaitan dengan kondisi yang dialaminya saat ini (Colom, 2011). Dalam perkembangannya psikoedukasi tidak hanya diperuntukkan untuk masalah kesehatan mental, tetapi meluas pada pengobatan dan rehabilitasi pasien dengan gangguan makan (*bullemia*) (Pettersen, Rosenvinge & Wynn 2011); penyakit diabetes (Cezaretto *et al.*, 2016), mencegah depresi *postpartum* (Ugarte *et al.*, 2017).

Psikoedukasi perlu diberikan pada pasien karena pemahaman tentang penyakit yang diderita pasien akan mendorong untuk mengendalikan penyakitnya, sehingga dapat menjalaninya dengan lebih baik (Yadav & Kumar,

2014). Sementara itu, melalui pendidikan, baik individu maupun kelompok, akan mendorong partisipasi aktif dalam manajemen diri dan mencegah kekambuhan serta meningkatkan kemampuan untuk deteksi dini (Colom, 2011; Perry *et al.*, 1999).

Psikoedukasi sering berfokus pada pendidikan tentang kesehatan mental, keterampilan mengatasi masalah, upaya pemberdayaan, atau komunikasi. Psikoedukasi dapat membantu dan disediakan dalam format individu, keluarga atau kelompok, tetapi tidak secara khusus tentang pengobatan. Hal ini diberikan oleh seorang profesional kesehatan mental berlisensi, tetapi mungkin juga disediakan oleh para ahli lain juga (Supratiknya, 2011). Dalam praktiknya, psikoedukasi memerlukan konseling dan psikoterapi (Cummings & Cummings, 2008).

Selain istilah psikoedukasi dan psikoterapi, juga dikenal istilah pendidikan kesehatan (*health education*) dan promosi kesehatan (*health promotion*). WHO (1998) menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan pada hakekatnya adalah mendukung perubahan perilaku individu, kelompok atau masyarakat menuju perilaku yang mendukung hidup sehat, agar dapat mengambil sikap yang bijaksana, menentukan keputusan terhadap kesehatan dan kualitas hidupnya, sedangkan promosi kesehatan merupakan proses untuk mendorong orang meningkatkan kontrol dan mengembangkan kesehatan diri.

Promosi kesehatan merupakan interaksi sinergis antara pendidikan kesehatan dan pengembangan kebijakan kesehatan (Fertman & Allensworth, 2010). Hal tersebut didukung oleh pernyataan bahwa promosi kesehatan didefinisikan sebagai kombinasi antara pendidikan kesehatan dengan dukungan organisasi, ekonomi,

lingkungan untuk mendukung perilaku sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat (Green dan Keuter, 1991, dalam Glanz *et al.*, 2008).

B. Fokus Psikoedukasi

Brown (2011) memberikan gambaran tentang grup psikoedukasi yang didefinisikan sebagai kelompok yang fokus utamanya adalah edukasi tentang topik atau konsep psikologikal. Dikatakan lebih lanjut bahwa psikoedukasi berfokus pada upaya edukasi tentang prevensi/pencegahan, sedangkan yang menjadi fokus psikoterapi adalah meningkatkan kesadaran diri dan upaya remediasi.

Fokus psikoedukasi meliputi juga menyediakan informasi untuk membantu coping individu terkait dengan krisis yang dihadapinya, isu yang berkembang atau mencegah timbulnya masalah. Intervensi psikoedukasi yang berfokus pada upaya prevensi, dapat meningkatkan pengetahuan individu tentang kondisi kesehatan dirinya, dan meningkatnya kemampuan diri untuk melindungi diri dengan mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi.

C. Psikoedukasi pada lansia

Pertumbuhan populasi yang meningkat di dunia menyebabkan berbagai masalah sosial dan kesehatan di antaranya adalah kesejahteraan psikologis dan kognitif lansia (Lim & Kua, 2011). Promosi kesehatan yang menargetkan lansia sangat penting untuk dilakukan mengingat perubahan demografis yang mengakibatkan kerentanan fisiologis dan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung pemerintah (Dubas-Jakóbczyk *et al.*, 2017). Perubahan konsep gerontologi dari menghindari penurunan kesehatan akibat

bertambahnya usia menjadi program promosi terhadap penuaan yang sehat.

Salah satu komponen kunci dari penuaan sehat yang optimal adalah mempertahankan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan emosional selama rentang kehidupan seseorang (Kryla-Lighthall & Mather, 2009). Berkurangnya kesejahteraan berkaitan dengan perubahan emosional dan fungsi kognitif lansia (Buchman *et al.*, 2014). Perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan partisipasi aktivitas fisik bagi lansia, yang mencakup: 1) meningkatkan kesadaran tentang manfaat aktivitas fisik dan meminimalkan risiko yang dirasakan akibat dari aktivitas fisik; 2) meningkatkan akses terhadap lingkungan dan keuangan (Franco *et al.*, 2015); 3) mempertahankan dan meningkatkan kapasitas fungsional lansia, mempertahankan atau meningkatkan kemampuan perawatan diri dan menstimulasi jejaring sosialnya (Golinowska *et al.*, 2016). Studi lainnya melengkapi dengan pendidikan kesehatan, modifikasi perilaku dan komunikasi kesehatan akan meningkatkan partisipasi aktivitas fisik lansia (Duplaga *et al.*, 2016). Promosi kesehatan lansia juga menargetkan bagaimana lansia dapat berkontribusi terhadap kualitas hidup lansia yang lebih baik dan mandiri (WHO, 2015). Salah satu intervensi yang bersifat edukatif agar lansia menyadari perlunya meningkatkan taraf kesehatannya yang dapat diterapkan secara individu atau kelompok adalah psikoedukasi (Abooe, 2017).

Psikoedukasi lansia yang memberdayakan peran *peer group* dalam setiap rancangan program intervensi mendorong lansia memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan intervensi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Studi *systematic review* dan meta-analisis, peran *peer group* dalam menjalani program latihan dan memberikan motivasi mampu

mempromosikan dan mempertahankan kepatuhan terhadap program latihan fisik (Burton *et al.*, 2017). Studi dengan metode *randomized control trial* (RCT) melaporkan adanya kelayakan dan efektivitas intervensi psikoedukasi lansia yang mengalami gangguan kognitif untuk meningkatkan kualitas hidup lansia (Young *et al.*, 2017). Sementara itu, intervensi yang dilakukan untuk lansia merupakan kombinasi antara aktivitas fisik maupun mental secara bersamaan, lebih efektif dalam mencapai tujuan program tersebut.

Studi meta-analisis gabungan intervensi (fisik maupun kognitif) pada lansia menunjukkan efek lebih baik dibandingkan dengan intervensi fisik saja ataupun hanya intervensi kognitif, sementara itu tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara intervensi gabungan dan intervensi kognitif terhadap kesehatan lansia (Zhu *et al.*, 2016). Studi meta-analisis lainnya melaporkan bahwa adanya efek kombinasi latihan fisik seperti ketahanan, peregangan dengan intervensi kognitif membantu meningkatkan kesehatan fisik serta memperbaiki kesehatan kognitif lansia terutama penalaran (Kelly *et al.*, 2014). Pengaruh juga dirasakan oleh lansia yang mengalami dimensia ringan, efek kombinasi ini selain meningkatkan kemampuan aktivitas juga memperbaiki kondisi kognitif lansia (Karssemeijer *et al.*, 2017). Dengan demikian, intervensi latihan fisik untuk lansia seharusnya dikombinasikan dengan intervensi kognitif seperti psikoedukasi.

Psikoedukasi lansia ditujukan untuk mempromosikan perilaku hidup sehat dan menciptakan serta meningkatkan kesadaran menuju kepuasan hidup. Studi yang dilakukan oleh Tambağ & Öz, (2013) pada lansia yang tinggal di panti menyatakan bahwa psikoedukasi dipengaruhi oleh usia, perilaku gaya hidup kesehatan dan kepuasan hidup serta

perpikir positif untuk menciptakan perubahan yang diinginkan.

Psikoedukasi dalam memperbaiki fungsi kognitif memberikan efek terhadap stabilitas perasaan, kontrol atas fungsi memori, mengurangi kekhawatiran tentang penurunan fungsi kognitif, mengurangi kecemasan tentang demensia dan meningkatkan upaya dalam mengatasi beban kognitif (Reijnders *et al.*, 2017).

D. Teori perlunya program psikoedukasi dan senam bugar lansia

Teori yang mendukung penting untuk melakukan psikoedukasi dan senam bugar pada lansia antara lain yaitu *the health belief model* (HBM), *theory of reasoned action* (TRA)/ *Theory of planned behavior* (TPB), dan *social cognitive theory* (SCT) (Fertman & Allensworth, 2010). Teori-teori tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. *The health belief model* (HBM)

Model ini bertujuan untuk memprediksi kondisi-kondisi yang mendasari individu menggunakan perilaku-perilaku preventif. *Health belief model* adalah model teoritis yang dirancang untuk menjelaskan perilaku kesehatan dengan memahami keyakinan individu tentang kesehatan. Pada awalnya digunakan untuk menjelaskan alasan seseorang bersedia terlibat dalam program pemeriksaan kesehatan dan imunisasi, dan telah dikembangkan untuk penerapan perilaku kesehatan lain. Pada intinya, *the health belief model* menunjukkan bahwa kemungkinan individu untuk mengambil tindakan atas masalah kesehatan yang dialami didasarkan pada interaksi antara empat jenis keyakinan (*perceived*

susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived threat).

Menurut model *health belief* ini, tindakan seseorang untuk mengubah perilakunya (atau kurangnya tindakan) merupakan hasil dari penilaian individu terhadap beberapa konstruk. Seseorang memutuskan dia rentan atau tidak (kerentanan yang dirasakan) terhadap suatu penyakit atau kondisi, dan beratnya tingkat keparahan penyakit atau kondisi (keparahan yang dirasakan). Jika seseorang percaya bahwa dirinya rentan dan penyakitnya cukup parah maka akan memotivasi untuk berubah, sehingga individu lebih mungkin mengambil tindakan.

Jika seseorang tidak percaya dirinya rentan, meskipun penyakitnya mungkin sudah parah, kemungkinan orang tersebut tidak akan melakukan tindakan. Individu juga mempertimbangkan manfaat dari tindakan untuk berubah (sesuai manfaat yang dirasakan), memperhatikan hambatan untuk berubah (hambatan yang dirasakan), dan analisis ini adalah faktor prediktif terkuat untuk perubahan perilaku (Janz, Champion & Strecher, 2002 dalam Fertman & Allensworth, 2010). Jika seseorang percaya bahwa manfaat lebih besar daripada hambatan, maka lebih cenderung mengambil tindakan untuk berubah. Isyarat untuk bertindak, seperti instruksi atau pengingat, juga dapat digunakan untuk memfasilitasi perubahan.

Model *health belief* juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti usia, jenis kelamin, dan kepribadian, dengan asumsi bahwa faktor-faktor ini dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk mengubah perilakunya. *Self-efficacy*, keyakinan seseorang bahwa dia mampu untuk terlibat dalam perilaku (Bandura, 1986

dalam Fertman & Allensworth, 2010), ditambahkan kemudian sebagai faktor dalam mempertahankan perilaku (Rosenstock, Strecher, & Becker, 1988 dalam Fertman & Allensworth, 2010).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ada empat tahap dalam model *Health Belief*, yaitu: 1) Individu menganggap dirinya rentan terhadap kondisi atau masalah penyakit; 2) Percaya bahwa kerentanan akan memiliki konsekuensi yang berpotensi serius; 3) Percaya tentang adanya suatu tindakan yang akan mengurangi kerentanannya, atau meminimalkan konsekuensi yang mungkin dapat terjadi; 4) Individu percaya bahwa manfaat dari mengambil tindakan akan lebih besar daripada biaya atau hambatan.

2. *Social cognitive theory (SCT)*

Teori ini merupakan teori yang paling banyak digunakan dalam promosi kesehatan karena ditujukan pada kedua faktor penentu yang mendasari perilaku kesehatan dan metode dalam mempromosikan perubahan. Teori ini dibangun atas pemahaman tentang interaksi yang terjadi antara individu dan lingkungan (Bandura 1999). Teori *Social Cognitive* (teori kognitif sosial) berevolusi dari teori belajar sosial, yang diciptakan oleh Albert Bandura pada awal 1960-an (Bandura & Walters, 1963 dalam Fertman & Allensworth, 2010). Pada tahun 1986, Bandura secara resmi meluncurkan teori *social cognitive* dengan bukunya: *Social cognitive theory*. Teori kognitif sosial mendefinisikan perilaku manusia sebagai interaksi faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan.

Teori kognitif sosial adalah paradigma yang paling sering digunakan dalam promosi kesehatan. Teori ini didasarkan pada determinisme timbal-balik antara

perilaku, lingkungan, dan individu. Bandura berpendapat bahwa individu belajar dari interaksi dan pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu ditentukan secara unik oleh tiga faktor berikut ini (Bandura, 1986): 1) Faktor pribadi: harapan, keyakinan, persepsi diri, tujuan, dan niat seseorang membentuk dan mengarahkan perilaku; 2) Faktor lingkungan: harapan manusia, keyakinan, dan kompetensi kognitif dikembangkan dan dimodifikasi oleh pengaruh sosial dan struktur fisik dalam lingkungan; 3) Faktor perilaku: Perilaku seseorang akan menentukan aspek lingkungan di tempat orang tersebut terpapar, dan perilaku, pada gilirannya, dimodifikasi oleh lingkungan tersebut.

Pemahaman tentang interaksi faktor-faktor tersebut dan cara modifikasi norma sosial dapat berdampak pada perilaku wawasan penting tentang cara perilaku dapat diubah melalui intervensi promosi kesehatan. Bandura telah mengidentifikasi beberapa konstruksi penting dari teori kognitif sosial, meliputi: *environment*, *situations*, *behavioral capacity*, *outcome expectations*, *outcome expectancies*, *self-control*, *observational learning*, *self-efficacy*, dan *emotional coping*. Konstruksi *self-efficacy* (efikasi diri) adalah salah satu konstruk psikososial yang paling dianalisis dalam penelitian.

Bandura (1997) mendefinisikan efikasi diri sebagai kepercayaan seseorang dalam kemampuannya untuk mengejar perilaku. Efikasi diri adalah perilaku spesifik dan ada di masa sekarang yang memainkan peran sentral dalam perubahan perilaku. Efikasi diri berfungsi sebagai panduan untuk dan motivator perilaku kesehatan dan berakar pada keyakinan inti bahwa seseorang memiliki

kekuatan untuk menghasilkan efek yang diinginkan melalui tindakan.

3. *Theory of planned behavior (TPB)*

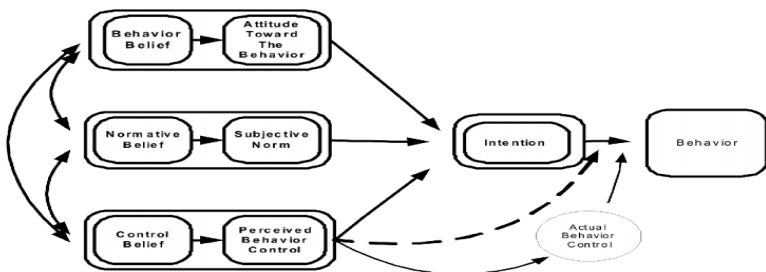
Teori ini merupakan bagian dari teori kognitif sosial yang menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku (Ajzen, 1991), yang mengasumsikan bahwa sikap individu terhadap hasil suatu perilaku merupakan faktor penting keterlibatan individu terhadap perilaku tersebut (Kosma, 2012).

Theory of Planned Behavior (TPB) perpanjangan dari *Theory of reasoned action* (Fishbein & Ajzen, 1977) dengan menambahkan konsep kontrol perilaku yang dirasakan untuk menjelaskan perilaku yang tidak di bawah kendali seseorang (Ajzen, 1991; Benjamin *et al.*, 2005). Teori ini sering digunakan untuk memprediksikan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan (Armitage & Conner, 2001; Conner & Sparks, 2005; Plotnikoff *et al.*, 2008) seperti diet (Nejad *et al.*, 2005), dan olah raga (Hausenblas *et al.*, 1999; Downs & Hausenblas, 2005; Rhodes *et al.*, 2006). Niat mencerminkan motivasi dan kemauan seseorang untuk terlibat dalam perilaku (Ajzen, 1991; Hagger & Chatzisarantis, 2005) yang merupakan penentu utama perilaku individu (Vallance *et al.*, 2011; Kosma, 2012).

Teori tindakan yang direncanakan (*theory of planned behavior*) menjelaskan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga faktor, yaitu: keyakinan (*belief*) tentang hasil perilaku yang diharapkan dan evaluasi hasil perilaku (*behavior belief*), keyakinan tentang harapan normatif (*normative belief*) dari orang lain, dan keyakinan akan hadirnya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku serta persepsi adanya kekuatan pada faktor

tersebut (control belief). Berdasarkan perspektif tersebut, keyakinan perilaku (behavior belief) menimbulkan sikap positif (favourable) atau negatif (unfavorable), terhadap perilaku tertentu, keyakinan normatif (normative belief) mengakibatkan terbentuknya persepsi adanya tekanan (pressure) sosial untuk melakukan tindakan atau norma subjektif (subjective norm), dan control belief menimbulkan persepsi atas kontrol perilaku (perceived behavior control) (Ajzen, 1991; Benjamin *et al.*, 2005; Machrus & Purwono, 2012). Selanjutnya, niat dijelaskan oleh tiga konsep independen, termasuk sikap terhadap perilaku, norma subjektif (tekanan sosial yang dirasakan berkaitan dengan perilaku tertentu), dan kontrol perilaku yang dirasakan (persepsi kemampuan untuk melakukan perilaku) (White *et al.*, 2012).

Secara bersamaan, konstruksi ini mewakili motivasi total seseorang untuk melakukan perilaku (Kwan & Bryan, 2010). Secara singkat, dengan sikap yang lebih positif, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang baik maka niat untuk melibatkan perilaku akan lebih kuat (Lin *et al.*, 2020). Kerangka teori *planned behavior* dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 3.1 Teori *planned behavior* (Ajzen, 1991)

Theory of planned behavior (TPB) sering digunakan untuk perubahan perilaku dalam senam lansia, karena perilaku lansia untuk melakukan senam memiliki banyak kendala dan hanya sampai batas tertentu berada di bawah kendali pribadi (Smith & Biddle, 1999), sehingga teori ini sering digunakan untuk memprediksikan dan menjelaskan motivasi untuk senam dan perubahan perilaku pada populasi umum di komunitas (Hausenblas *et al.*, 1999; Hagger *et al.*, 2002; Rhodes *et al.*, 2006; Vallance *et al.*, 2011). Secara khusus, beberapa penelitian telah menerapkan TPB untuk perilaku olah raga pada orang dewasa yang lebih tua atau lansia (Chase, 2013; French, 2014; Geraedts, 2013, Hobbs *et al.*, 2013; dan Muller, 2014; Kosma, 2012).

Niat untuk melakukan aktivitas fisik senam biasanya akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia (Rhodes *et al.*, 1999; Yardley *et al.*, 2007). Sementara itu, Yardley *et al.* (2007) melaporkan adanya hubungan negatif antara usia dan niat senam pada lanjut usia. Artinya, makin tua usia lansia, niat melakukan senam semakin menurun. Lansia umumnya menerjemahkan niat untuk senam dengan selalu memperhatikan usia mereka (Hagge *et al.*, 2002). Teori ini juga terbukti efektif untuk intervensi fisik dalam mempertahankan keberlangsungan aktivitas lansia (Gourlan *et al.*, 2016).

Bab 4

Senam Sehat Bugar Lansia

A. Aktivitas fisik

Aktivitas fisik didefinisikan sebagai gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang menghasilkan pengeluaran energi di atas tingkat istirahat. Definisi ini mencakup keseluruhan aktivitas manusia yang mungkin melibatkan gerakan tubuh seperti bermain sepak bola, *jogging*, jalan kaki, bersepeda, menari, berkebun dan pekerjaan rumah. Ketahanan aktivitas fisik pada laki-laki lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Usia menentukan lansia dalam melakukan aktivitas fisik (Sun *et al.*, 2013).

Studi longitudinal aktivitas fisik yang dilakukan pada lansia di Korea melaporkan bahwa lansia yang mempertahankan atau meningkatkan aktivitas fisik membantu meningkatkan fungsi kognitif (Lee *et al.*, 2015; Lindwall *et al.*, 2012). Sementara itu, studi RCT melaporkan bahwa penambahan intervensi aktivitas fisik yang memberikan efek terhadap ketahanan perlu dilakukan karena mampu menurunkan skor kelemahan dan meningkatkan kekuatan otot tungkai bawah dan kelemahan mobilitas pada lansia (Nagai *et al.*, 2018). Aktivitas fisik juga memberikan efek positif terhadap vitalitas lansia (Olsson *et*

al., 2014; Ryan *et al.*, 2010) yang bermanfaat memberikan makna terhadap kehidupan (Ju, 2017). Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan vitalitas (kebugaran) dan mengurangi kelelahan. Lansia yang tidak memiliki makna dalam kehidupannya cenderung mengalami depresi, dan memiliki perasaan tidak berarti (Frankl, 2017).

Aktivitas fisik lansia perlu didorong agar mendapatkan dukungan baik dari sesama lansia maupun lingkungannya. Salah satu bentuk dukungannya adalah penyesuaian intervensi aktivitas fisik lansia (Aartolahti *et al.*, 2015) serta terbentuknya ikatan sosial yang membantu dalam memelihara kepatuhan dan peningkatan aktivitas fisik (Fu *et al.*, 2018). Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah status sosial ekonomi, aspek perilaku, kepercayaan diri dan kemandirian mendorong lansia mempertahankan aktivitas fisik (Mosallanezhad *et al.*, 2017). Sementara itu, kebiasaan berjalan pada lansia sehat berhubungan dengan risiko jatuh, namun risiko jatuh tidak terjadi pada lansia berisiko (Okubo *et al.*, 2015). Lansia dengan masalah kesehatan mampu melakukan aktivitas fisik berjalan, melakukan senam lansia meskipun dilakukan dengan hati-hati.

Interaksi sosial yang terjadi saat lansia melakukan aktivitas fisik mendukung kepatuhan lansia dalam beraktivitas fisik secara teratur dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan lansia yang melakukan aktivitas fisik akan membangun interaksi sosial dengan sesama lansia guna mendapatkan dukungan di antara mereka (Jansons *et al.*, 2018). Sementara itu, lingkungan yang mendukung terjadinya interaksi sosial adalah lokasi yang memungkinkan lansia dapat berjalan maupun bersepeda dengan nyaman (Duan *et al.*, 2018).

Lansia memiliki gaya hidup menetap dan cenderung depresif yang mungkin saja dapat menimbulkan permasalahan kesehatan mental pada lansia. Lansia yang memiliki kebiasaan beraktivitas fisik akan mendukung kondisi kesehatan psikologis yang berdampak pada penguatan fungsi fisiologis. Penguatan fungsi fisiologis dalam beraktivitas mendorong kualitas hidup lansia menjadi lebih baik (Sertel *et al.*, 2017).

Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang menghasilkan pengeluaran energi di atas tingkat istirahat (Bouchard & Shephard, 1994). Aktivitas fisik adalah set dasar, yang berisi semua konsep, bahkan definisi tersebut mencakup semua jajaran kemungkinan kegiatan manusia yang melibatkan gerakan tubuh seperti bermain sepak bola, jogging, berjalan, bersepeda, menari, berkebun dan pekerjaan rumah (Cavill *et al.*, 2006). Case (1985) mengemukakan bahwa seseorang harus mengelompokkan kegiatan fisik atas dasar bagian-bagian yang dapat diidentifikasi dari kehidupan sehari-hari selama beraktivitas. Efek intervensi aktivitas fisik dilakukan bahwa jenis kelamin (pria lebih aktif) dan usia (lansia muda lebih aktif dibandingkan dengan yang lebih tua) lebih sering ditemukan pada program aktivitas fisik (Lehne & Bolte, 2017).

Melalui perbedaan batasan aktivitas fisik dimungkinkan untuk membedakan aktivitas fisik yang dilakukan, misalnya, saat bekerja dan selama waktu senggang atau luang. Dalam kategorisasi ini, kegiatan rekreasi dapat dikategorikan dalam pekerjaan, olah raga, atau kegiatan rumah tangga (Case, 1985). Kategori lain adalah kategori yang mengklasifikasikan semua aktivitas fisik ke dalam intensitas ringan, sedang, atau berat; yang

disengaja atau wajib; yang merupakan kegiatan hari kerja atau akhir pekan. Hal ini merupakan kategorisasi operasional yang sehat.

Banyak Peneliti (Ainsworth *et al.*, 2000; Caspersen, Christenson, & Pollard, 1986; Dishman, Sallis, & Orenstein 1985; Hagströmer, 2007; King, 2001) mempertimbangkan ciri aktivitas fisik melalui modus, intensitas, durasi, frekuensi dan kontinuitasnya dalam kategori sebagai berikut:

1. Mode mengacu pada jenis aktivitas atau keadaan di tempat aktivitas dilakukan.
2. Intensitas merupakan pengeluaran energi (ringan, sedang, kuat) sementara suatu kegiatan dilakukan.
3. Durasi adalah pengukuran waktu (biasanya diberikan dalam jam atau menit) di kegiatan yang dilakukan.
4. Frekuensi adalah banyaknya (biasanya per minggu atau bulan) aktivitas dijalankan.
5. Kontinuitas adalah periode waktu aktivitas dilakukan.

Pengkategorian aktivitas fisik ini melalui mode, intensitas, durasi, frekuensi, dan kontinuitas dapat diterapkan ke semua rentang aktivitas fisik (termasuk olah raga) dan memungkinkan deskripsi dan kategorisasi yang tepat. Aktivitas fisik yang direkomendasikan bagi lansia meliputi frekuensi, durasi, dan intensitas yang dianjurkan untuk lansia makin berkurang. Kegiatan yang ada dalam tujuh rekomendasinya terperinci dalam empat kasus kegiatan berorientasi olahraga dan dalam tiga kasus kegiatan sehari-hari. Dalam kategori ini tidak ada indikasi kontinuitas (Michelli, 2015).

Aktivitas fisik secara teratur dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan kepada lansia dan kebutuhan aktivitas fisik yang akan berlangsung terus

menerus. Bukti empiris menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat memperpanjang umur lansia, dengan lansia sebagai individu mandiri yang aktif. Aktivitas fisik juga terbukti mengurangi kecacatan dan meningkatkan kualitas hidup lansia (United Nation, 2015; Wen *et al.*, 2011).

Meningkatnya aktivitas fisik dapat meminimalkan beban terhadap upaya kesehatan dan perawatan sosial lansia melalui upaya proses menua yang sehat (Davis *et al.*, 2015; Salem & Sinner, 2011). Meningkatnya populasi lansia telah membawa tuntutan baru untuk meningkatkan kesehatan lansia dengan menambahkan upaya peningkatan kualitas hidup lansia (Bowling, 2009). Kajian ini dilakukan Mummery *et al.* (2007), dengan latar belakang rekomendasi WHO untuk aktivitas fisik pada lansia yang berusia 65 tahun (WHO, 2010).

Rekomendasi pentingnya aktivitas fisik bagi lansia adalah meningkatkan beban kesehatan (Lee *et al.*, 2012), aktivitas fisik dengan pengawasan pada lansia merupakan salah satu prioritas kesehatan masyarakat untuk pengembangan program pencegahan penyakit tidak menular yang efektif (Hallal *et al.*, 2012). Aktivitas fisik pada lansia sangat diperlukan sebagai strategi promosi kesehatan masyarakat yang dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup lansia (Macera & Pratt, 2006).

B. *Physical exercise* (latihan fisik)

Latihan fisik atau latihan adalah bagian dari aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, dan berulang dan memiliki tujuan akhir atau menengah untuk peningkatan atau pemeliharaan kebugaran fisik. Secara lebih rinci, Haag dan Haag (2003) menganggap latihan fisik menjadi totalitas semua kegiatan motorik yang diwujudkan dalam pembelajaran motorik, berolahraga (pelatihan) dan

kompetisi olahraga. Mereka membedakan antara olahraga sebagai proses dan sebagai hasilnya. Sebagai suatu proses, latihan adalah pengulangan urutan gerakan yang telah ditentukan sebelumnya (berolahraga) dengan berbagai tingkat intensitas, sebagai hasilnya, olahraga adalah bagian dari kinerja atau presentasi motorik yang komprehensif (Haag & Haag, 2003).

Penting untuk memperjelas bahwa latihan fisik didefinisikan sebagai olahraga pada waktu luang dan bukan selama bekerja (Pietilä *et al.*, 1995) dan bahwa tujuan latihan fisik adalah peningkatan atau pemeliharaan satu atau lebih komponen kebugaran fisik. Di negara Barat (tahun 1970-an) istilah ini diganti istilah olahraga, yang meskipun memiliki makna holistik, mengandung bahaya melekat dalam membatasi arti istilah untuk olahraga dan kompetisi kinerja tinggi (Haag & Haag). Perbedaan antara latihan dan olahraga adalah bahwa jika semua olahraga melibatkan latihan fisik, tetapi tidak semua latihan fisik merupakan olahraga, karena komponen olahraga yang diperlukan seperti elemen kompetitif, sering tidak ada dalam bentuk latihan fisik (Waddington *et al.*, 1997).

Physical exercise atau latihan fisik atau hanya disebut *exercise* adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, yaitu aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, dan berulang-ulang dan memiliki tujuan untuk peningkatan atau pemeliharaan kebugaran fisik. Secara lebih rinci, Haag dan Haag (2003) mempertimbangkan latihan fisik untuk menjadi semua aktivitas motorik yang direalisasikan dalam pembelajaran motorik, latihan (*exercise*) dan kompetisi olahraga secara total menyeluruh (Michelin, 2015).

Ada kebutuhan program yang mempromosikan pentingnya melakukan latihan fisik dan atau aktivitas fisik,

sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan secara terus menerus. Mortenson *et al.* (2017) dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Non Digital Game Playing by Older Adults*, menunjukkan bahwa bagi populasi lanjut usia, permainan non digital adalah penting, karena permainan tersebut bersifat sosial dan umumnya menyenangkan lansia untuk membantu menjaga kemampuan kognitifnya. Selain itu, juga menyarankan perlunya upaya untuk memfasilitasi aktivitas fisik yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan kualitas hidup lansia.

Mengingat tingkat ketidak-aktifan yang diamati pada lansia dengan berbagai hambatan dan kenyataan bahwa ketidak-aktifan dalam aktivitas fisik menyebabkan masalah kesehatan yang serius, maka perlu panduan yang tepat yang harus diberikan untuk mempromosikan pentingnya aktivitas fisik. Justine *et al.* (2013), menyatakan bahwa program latihan yang menyenangkan dan nyaman harus dirancang untuk menarik perhatian lansia yang lebih tidak aktif dan mendorong untuk melakukan latihan fisik dan aktivitas fisik yang direkomendasikan.

Meskipun manfaat kegiatan aktivitas fisik dan olah raga diakui secara luas, tetapi banyak lansia yang mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas fisik. Pham *et al.* (2007), menemukan bahwa tiga hambatan eksternal yang paling penting di antara wanita paruh baya (lansia) untuk melakukan latihan fisik adalah: tidak memiliki cukup waktu, keterampilan dan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari keluarga. Schutzer dan Graves (2008) juga melaporkan bahwa lansia menilai latihan fisik sebagai prioritas terendah dalam kehidupannya.

Kurangnya fasilitas juga menjadi hambatan penting untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan latihan. Schuler

et al. (2006) yang menyoroti hambatan dan motivasi untuk melakukan aktivitas fisik pada lansia wanita, ditemukan bahwa latihan fisik mengganggu aktivitas sosial. Selain itu, Buman *et al.* (2010), menunjukkan bahwa populasi lansia memiliki kesadaran rendah mengenai efek latihan fisik dan aktivitas fisik yang menguntungkan bagi kesehatan dirinya.

Hambatan internal terhadap latihan fisik pada orang lanjut usia yang ditemukan oleh Sallinen *et al.* (2009) adalah faktor kelelahan dan obesitas. Menurut Chao *et al.* (2000), motivasi diri akan menentukan partisipasi seseorang dalam aktivitas fisik secara terstruktur. Daskapan *et al.* (2006) dalam penelitiannya menemukan kurangnya motivasi sebagai satu hambatan, mengingat tingkat aktivitas fisik dan kesehatan lansia telah mengalami perubahan fisiologis terkait dengan faktor usia.

C. Aspek-aspek pendukung aktivitas fisik / senam lansia

Beberapa aspek yang dapat mendukung aktivitas partisipasi lansia dalam kegiatan aktivitas fisik secara terstruktur seperti senam bugar lansia yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan lansia, antara lain: *cognitive emotional function*, dan *social activity (participation)*, yang diuraikan sebagai berikut.

1. *Cognitive emotional function*

Cognitive emotional function atau kesesuaian perpaduan antara fungsi neurologis dan afektif dalam proses penuaan yang mengindikasikan bahwa fungsi kognitif merupakan faktor penting dalam mempromosikan kesejahteraan emosional di akhir hidup lansia (Katz & Maeir, 2011). Dalam hal ini, lansia mengalami peristiwa kehidupan yang negatif seperti menurunnya fungsi kognitif dan kesehatan lansia, seiring

dengan penambahan usia (Levi, 2011), termasuk kesejahteraan emosional.

Kesejahteraan dan kepuasan hidup serta status kognitif dan emosional lansia, dipengaruhi oleh jaringan sosial, pengaturan hidup, dan kegiatan rekreasi. Golden *et al.*, (2009) menyatakan bahwa jaringan sosial dan kesepian atau kesendirian mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan lansia. Penelitian longitudinal bentuk studi kohort yang dilakukan oleh Gow *et al.* (2012), menunjukkan bahwa partisipasi yang lebih luas dalam aktivitas secara konsisten meningkatkan kemampuan kognitif lansia. Temuan ini menunjukkan hubungan antara partisipasi aktivitas fisik dan status kognitif-emosional

2. *Social activity (participation)*

Partisipasi baik di rumah maupun masyarakat dengan menyediakan sarana untuk kegiatan fisik, kognitif dan sosial bagi lansia, merupakan dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan lansia (Gow *et al.*, 2012). Kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan status fisik, mental, dan sosial yang kompleks, penuh dengan kesenangan dan kepuasan hidup secara menyeluruh (Christiansen, 2005). Okupasi dan berbagai aktivitas yang bermakna mendukung lansia untuk berpartisipasi dalam peran hidup lansia. Kesehatan yang dikaitkan dengan kesejahteraan psikososial, akan memfasilitasi partisipasi lansia dalam pekerjaan yang bermakna serta keterlibatan berkelanjutan sepanjang hidup (Wilcok, 2005). Fungsi kognitif dan fisik, serta kesehatan dan partisipasi dalam pekerjaan yang berarti, telah digambarkan sebagai lansia sukses dalam proses penuaan (Minhat and Amin, 2012).

Menurut WHO (World Health Organization) sehat adalah suatu keadaan sehat fisik, mental, dan juga

sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mencakup tiga aspek yang saling berkaitan satu sama lain, dan tidak hanya berarti bebas dari penyakit dan kelemahan. Bugar merupakan kemampuan individu untuk melakukan fungsinya secara efisien dan efektif, serta mampu melakukan kegiatan darurat tanpa merasa lelah. Semakin bugar kondisi jasmani seseorang, maka derajat kesehatannya juga akan semakin meningkat. Dengan penjelasan di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa kondisi sehat seseorang sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi bugar atau tidaknya jasmani orang tersebut. Semakin tinggi kemampuan jasmani seseorang dalam melakukan kegiatan, berarti tingkat kebugaran tubuh juga tinggi. Jika tingkat kebugaran yang dimilikinya tinggi, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut memiliki jasmani yang juga sehat.

Keterlibatan peer group dalam program latihan fisik (senam) mendorong kepatuhan dan efektif dalam mempromosikan pelibatan lansia dalam kegiatan tersebut (Burton *et al.*, 2017). Partisipasi ini diharapkan mampu meningkatkan atau mempertahankan kesehatan fisik dan juga membantu memperbaiki kesehatan mentalnya (Tomioka *et al.*, 2017). Bahkan aktivitas fisik terstruktur misalnya *exergame*, lansia yang terlibat mampu memberikan manfaat psikologis (seperti harga diri, konsentrasi, suasana hati, alasan, memori dan kesejahteraan), manfaat fisik (seperti kelincahan dan kondisi fisik) dan interaksi sosial (seperti pertukaran pengalaman, persahabatan dan daya saing) yang pada akhirnya akan mendorong kepatuhan untuk berolah raga serta meningkatkan motivasi dalam aktivitas fisik (Meneghini *et al.*, 2016). Studi lain melaporkan bahwa

kontrol sosial dan dukungan sosial dapat meningkatkan atau mengurangi aktivitas fisik lansia di masa mendatang (Newsom *et al.*, 2018).

Determinan kesehatan menekankan pentingnya meningkatkan dan mempertahankan perilaku sehat pada lansia (Goldberg, 2017). Jika determinan kesehatan lansia membaik, maka akan merepresentasi secara sosial kualitas hidup lansia (Ferreira *et al.*, 2017). Determinan berasal dari internal lansia berupa kelelahan, obesitas, kurangnya motivasi, merasa sudah aktif sedangkan determinan eksternal berupa olahraga, mengganggu aktivitas sosial/keluarga, persepsi bahwa olah raga terlalu mahal (Manaf, 2013).

Program aktivitas fisik senam bugar lansia mengembangkan mekanisme persuasif untuk memotivasi orang lansia untuk menjaga tingkat interaksi sosial dan fisik yang sehat (Romero *et al.*, 2010), sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan pendekatan transisi yang memerlukan solusi modular dan fleksibel yang memungkinkan orang mengembangkan kegunaan yang berbeda dari waktu ke waktu. Kemudian merancang motivator timbal balik, mengidentifikasi komponen persuasif yang menyenangkan untuk menawarkan mekanisme dalam memotivasi sekaligus membangkitkan pengalaman menyenangkan.

Program senam bugar lansia menjadi ajang sosialisasi bagi lansia untuk mengembangkan kemampuannya mengenali lansia lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut (Tomioka *et al.*, 2017). Sosialisasi yang terjadi di antara lansia difasilitasi oleh kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik di antara para lansia. Sosialisasi terbentuk sebagai akibat dari partisipasi aktif lansia pada

kegiatan aktivitas fisik dalam hal ini senam bugar lansia (Burton *et al.*, 2017).

Program senam bugar lansia dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan sehingga mendorong lansia untuk menikmati kegiatan tersebut. Cara membangun lingkungan yang memiliki suasana rekreasi yang baik dan menyenangkan bagi lansia dengan melakukan suatu aktivitas yang menyenangkan seperti adanya game, humor. Upaya aktivitas fisik lansia dalam kegiatan ini dapat meningkatkan interaksi sosial lansia yang pada pada akhirnya memberikan efek terhadap kualitas hidup lansia (Mortenson *et al.*, 2017).

D. Kearifan lokal dalam promosi kesehatan melalui Program Psi-Segar Lansia

Kearifan lokal terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti setempat dan *wisdom* artinya kebijaksanaan. Secara keseluruhan makna dari kearifan lokal (*local wisdom*) adalah ide, gagasan, nilai-nilai dan pandangan dari wilayah setempat, yang sifatnya bijaksana, penuh kearifan, nilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat (Wiranto, 2012).

Kearifan lokal juga didefinisikan sebagai pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh masyarakat lokal melalui akumulasi pengalaman dalam cobaan dan diintegrasikan dengan pemahaman tentang alam dan budaya sekitarnya (Wagiran, 2012). Berdasarkan defisi tersebut dapat diambil konsep sebagai berikut (1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan

dengan zamannya (Wagiran, 2012). Kearifan lokal berfungsi sebagai *blue print* atau pedoman bagi sikap dan perilaku bersama anggota kesatuan sosial tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya (Unayah & Sabarisman, 2016)

Kearifan lokal digali dari produk kultural yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan cara dinamika kehidupan itu berlangsung (Sibarani, 2012), sehingga kearifan lokal dapat berfungsi sebagai: 1) penanda identitas sebuah komunitas; 2) elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan; 3) unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (bottom up); 4) akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground yang dimiliki; 5) mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi dan mekanisme membangun solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi (Banda, 2016). Kearifan lokal sangat fleksibel dan dinamis yang terkait dengan kehidupan manusia dengan lingkungannya dan dapat dijadikan filter terhadap perubahan di era globalisasi.

Kearifan lokal dapat dijadikan media guna mendorong masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatannya terutama pada kelompok usia rentan seperti lansia. Berbagai upaya kesehatan lansia dapat dipertahankan keberlangsungannya melalui pendekatan kearifan lokal. Studi tentang aktivitas fisik lansia dibarengi psikoedukasi dengan memanfaatkan kearifan lokal diharapkan mampu mendorong adanya partisipasi sosial, interaksi dan komunikasi positif yang mampu menjadi kontrol sosial,

pemahaman tentang kondisi lansia serta mampu mempertahankan aktivitas fisik berkesinambungan. Program ini dilaksanakan dengan memanfaatkan filosofi budaya jawa seperti kerukunan, saling menghormati dan "*nrima*" (penerimaan situasi yang ada) terhadap kebahagiaan dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Karmiyati & Amalia, 2018).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui aktivitas *samper konco* (mengajak lansia lain), *tulong tinulong* (tolong menolong), *nyengkuyung* (keterlibatan), *panyengkuyung* (partisipasi) guna mendukung aktivitas sosial. Aktivitas lain dalam program ini diharapkan lansia memiliki komunikasi dan interaksi yang sehat antar sesama lansia melalui kegiatan *sesrawungan* (bergaul dengan sesama), *tepo seliro* (tenggang rasa, bentuk saling menghormati), *gethok tular* (saling berkabar). Aktivitas sosial yang terkoordinasi dan direncanakan dengan baik mampu memperbaiki tekanan psikologis (Owari *et al.*, 2018), sehingga dapat menekan efek kesepian dan isolasi sosial lansia di komunitas (Luptáková & Antala, 2017).

Upaya promosi kesehatan untuk menarik lansia agar tertarik mengikuti psikoedukasi dan senam dapat dilakukan dengan memanfaatkan tradisi setempat seperti iringan lagu senam dengan latar belakang lagu jawa. Pemanfaatan tradisi atau budaya mampu menarik perhatian individu maupun masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas berkelompok yang memberikan dampak langsung terhadap kesehatan lansia (Ong-artborirak & Seangpraw, 2019).

Bab 5

Kesehatan Mental Lansia

A. Konsep Kesehatan Jiwa pada Lansia

Proses menua dan menjadi lanjut usia (Lansia) merupakan proses alami yang disertai dengan penurunan kondisi fisik, psikologis, dan sosial serta saling berinteraksi satu sama lain. Proses menjadi lanjut usia tidak dapat dihindari. Bagi setiap orang yang sedang mengalami proses perkembangan menjadi lansia perlu memahami segala perubahan yang terjadi. Penuaan adalah proses alami yang dialami oleh setiap individu. Namun, proses ini seringkali dihubungkan dengan penurunan kualitas hidup, terutama dalam hal kesehatan mental. Lansia seringkali mengalami perubahan fisik, sosial, dan emosional yang signifikan, sehingga mempengaruhi kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk menghadapi stres, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi pada masyarakat. Kesehatan mental yang baik memungkinkan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa faktor yang pada umumnya mempengaruhi kesehatan mental lansia, antara lain:

1. Faktor biologis: merupakan faktor yang menunjukkan lansia mengalami penurunan fungsi fisik, penyakit kronis, dan akibat dari penggunaan obat-obatan.
2. Faktor psikologis: karena mengalami kehilangan pasangan, anak, atau teman, serta perubahan peran sosial.
3. Faktor sosial: Keterisolasian atau dikucilkan, kurangnya dukungan sosial, dan perubahan lingkungan.
4. Faktor ekonomi: Keterbatasan sumber daya keuangan dan akses ke layanan kesehatan.

Kesehatan jiwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penuaan. Bagi sebagian orang, menjadi lansia adalah salah satu hal yang tidak diinginkan. Keadaan tersebut tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa lansia. Gangguan kesehatan mental yang paling umum terjadi pada kelompok usia ini adalah demensia dan depresi, yang masing-masing memengaruhi sekitar 5% dan 7% populasi lansia di dunia. Masalah mental lainnya yang sering dialami lansia adalah amnesia, insomnia, sleep apnea dan *alzheimer's disease* (Nugroho, 2021).

Lansia sangat rentan mengalami masalah kesehatan mental. Kerentanan ini dikarenakan lansia mudah mengalami stress. Penyebab lansia mudah mengalami stress adalah mereka umumnya mengalami penurunan kemampuan fungsional tubuh yang menyebabkan lansia mudah lelah, mengalami berbagai penyakit dan mobilitasnya menurun. Selain itu, lansia sering mengalami masa berkabung karena kehilangan seseorang atau penurunan status ekonomi karena masa pensiun. Kerentanan terhadap stress karena lansia sangat rentan terhadap pelecehan baik verbal, fisik, psikologis, keuangan maupun pelecehan seksual.

Selain lansia rentan terhadap kondisi stress, kecukupan nutrisi akan mempengaruhi kondisi fisik lansia. Oleh karena itu, kebutuhan nutrisi ini menjadi penting dalam memelihara kesehatan fisik lansia. Beberapa sumber makanan seperti makanan sumber karbohidrat, sumber protein, sayur-sayuran, buah-buahan dan sumber lemak sehat. Selain itu, lansia juga harus membatasi konsumsi gula, garam dan lemak agar terhindar dari berbagai risiko penyakit degeneratif (Erisman dkk., 2020). Dalam studi literatur yang dilakukan Kristi dan Mahmudiono (2022), diketahui terdapat beberapa zat gizi yang dapat mencegah gangguan kesehatan mental. Beberapa diantaranya yaitu asam lemak omega 3, asam folat, protein, vitamin B12, selenium, zinc dan probiotik. Zat gizi ini dapat membantu menjaga kesehatan saraf dan otak, menjaga suasana hati, mengurangi kecemasan dan berfungsi sebagai antidepresan. Bahan makanan yang dapat dikonsumsi adalah daging, ikan, yoghurt, produk susu, oatmeal, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayuran.

B. Masalah Kesehatan Mental lansia

Lansia mengalami beberapa permasalahan kesehatan mental yang sering terjadi adalah stress, gangguan cemas, depresi, paranoid dan demensia (Nugraha, 2021). Adapun gejala gangguan kesehatan mental pada lansia antara lain depresi, kecemasan, gangguan tidur, gangguan memori, agresi-agitasi, perasaan terisolasi. Masalah-masalah kesehatan mental pada lansia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Stres

Stres yang terjadi pada lansia diakibatkan oleh proses ageing, dimana lansia mengalami perubahan fisik

sebagai akibat dari proses menua. Perubahan ini merupakan proses fisiologis, namun beberapa lansia terganggu karena proses ini. Beberapa penyebab stress yang dialami lansia adalah (Erisman dkk., 2020).

- a. Perubahan fisik yang mulai menurun akibat proses menua
- b. Keluarga yang kurang perhatian terhadap kondisi lansia
- c. Lingkungan yang telah berubah. Hal ini dikarenakan beberapa teman sebaya atau teman dekat telah meninggal, kehilangan kontrol dalam berhubungan dengan orang lain.
- d. Perubahan kondisi psikologis lansia seperti merasa takut menjadi tergantung pada anak, takut ditinggalkan pasangan dan perubahan cara pandang yang sempit akibat proses menua.

2. Gangguan kecemasan (WHO, 2021)

Gangguan kecemasan seringkali dihadapi lansia di kehidupan sehari-hari. Gangguan cemas yang menyebabkan lansia terganggu adalah:

- a. Perasaan berlebihan terhadap sesuatu yang telah terjadi, seperti kehilangan, kematian
- b. Sulit tidur di malam hari. Gangguan tidur di malam hari menyebabkan lansia sangat rentan terhadap kecemasan.
- c. Mudah tegang dan lekas marah. Lansia yang sering menghadapi ketegangan di lingkungannya akan memicu untuk mudah marah dan gampang tersinggung.
- d. Sering kepikiran terhadap peristiwa sehari-hari, sehingga lansia membayangkan hal-hal menakutkan.

- e. Perubahan fisik menyebankan lansia sering mengeluhkan kondisi fisiknya dan takut menderita penyakit berat seperti kanker, jantung dan lain-lain, meskipun lansia tidak sedang menderita penyakit tersebut.

3. Depresi (Alhawari & Pratiwi, 2021)

Depresi merupakan salah satu penyakit mental yang sering dialami lansia. Perasaan tertekan yang ditimbulkan akibat ketidak sesuaian antara yang diinginkan dengan realitas yang ada, memicu lansia mengalami depresi. Sejalan bertambahnya usia seseorang, maka kecenderungan mengalami depresi juga meningkat. Gangguan depresi pada lansia dapat terjadi dengan berbagai gejala, seperti sulit tidur, nyeri otot dan sendi. Gangguan cemas, kurang nafsu makan, dan bahkan ada kecenderungan untuk bunuh diri.

4. Paranoid (Faidah et al., 2021)

Menurunnya kontak dengan lingkungan, memunculkan perilaku *sedentary*. Perilaku ini selain menyebabkan lansia malas beraktivitas fisik, interaksi lansia dengan orang lain makin terbatas. Kehilangan kontrol interaksi dan perilaku yang malas bergerak menyebabkan lansia mudah curiga dengan orang lain. Selain itu, paranoid yang terjadi disebabkan oleh:

- a. Munculnya perasaan yang mengancam integritas lansia
- b. Merasa orang lain membicarakannya dan berkomplot untuk mencelakainya
- c. Perasaan memusuhi anggota keluarga dengan prasangka yang tidak mendasar.

5. Demensia (A-Finatunni'mah & Nurhidayati, 2020).

Demensia adalah penurunan fungsi daya ingat dan berpikir yang berlangsung kronik dan progresif sehingga menyebabkan gangguan fungsi aktivitas sehari-hari. Demensia adalah kumpulan penyakit dengan gejala yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan berinteraksi dengan orang lain.

Penyebab demensia adalah kerusakan pada sel-sel saraf otak (dapat terjadi pada beberapa area otak). Gangguan pada fungsi otak ini dapat muncul dalam berbagai kondisi yang berbeda pada setiap orang, tergantung dari area otak yang terdampak.

Salah satu gejala paling menonjol adalah sering lupa/pikun. Berbeda dengan lupa pada umumnya, ODD (Orang Dengan Demensia) akan kesulitan untuk mengingat suatu hal yang baru saja terjadi. Hal ini membuat ODD cenderung mengulang cerita atau bertanya hal yang sama berkali-kali.

Gejala yang sering di temukan lansia dengan demensia adalah:

- a. Sering lupa dengan kejadian-kejadian yang dialami.
Dalam keadaan yang lebih berat dapat lupa dengan nama sendiri dan keluarganya
- b. Mengabaikan kebersihan diri
- c. Sering mengulang-ulang kata atau pertanyaan
- d. Sering lupa waktu dan tempat
- e. Sifat dan perilaku berubah menjadi keras kepala dan cepat marah

C. Upaya pencegahan masalah gangguan mental lansia

Beberapa upaya untuk mencegah masalah gangguan kesehatan mental lansia adalah dengan melakukan aktivitas sehari-hari bersama dengan teman sebaya. Meskipun

terdapat perbedaan status sosial di masyarakat, perlu nya aktivitas rutin yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan bersama. Selain itu, beberapa aktivitas yang dapat dilakukan bersama lansia untuk memelihara kesehatan mentalnya antara lain, yaitu:

1. Rekreasi

Rekreasi merupakan aktivitas yang dapat membuat lansia merasa bermakna. Aktivitas dalam mengisi waktu luang lansia melalui kegiatan sosial akan membantu meningkatkan harga diri lansia. Rekreasi membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan sosialisasi dan rekreasi, sehingga dapat mengurangi stress.

2. Mengikuti aktivitas keagamaan

Aktivitas keagamaan merupakan sarana berinteraksi dengan orang lain dan berada dalam komunitas orang baik. Sehingga akan membantu lansia berpikir positif dalam menghadapi hidup. Lansia menjadi lebih tenang dan sabar dalam situasi yang menyebabkan stress.

3. Memperbanyak aktivitas bersama keluarga

Menghabiskan waktu bersama keluarga terdekat dapat memberikan rasa aman dan nyaman sehingga dapat menjaga suasana hati dan mengurangi stress pada lansia.

4. Mengikuti komunitas yang disukai

Dengan mengikuti kegiatan di komunitas yang disukai, lansia akan mampu menjaga hubungan sosial, cara berkomunikasi dan menghilangkan rasa bosan.

5. Mengikuti Program Psi-Segar

Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik lansia, tetapi kebutuhan psikologis, sosial dan

lingkungan yang sesuai dengan situasi lansia saat ini. Dengan program ini, segala permasalahan berkaitan dengan lansia akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya saat ini.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, untuk menjaga kesehatan mental lansia, strategi-strategi berikut ini juga perlu dikembangkan, yaitu: 1) Aktivitas fisik: seperti berjalan, berenang, atau yoga untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental; 2) Terapi kognitif: dengan cara mengembangkan kemampuan kognitif melalui permainan, puzzle, atau kegiatan kreatif; 3) Dukungan sosial: membangun hubungan dengan keluarga, teman, atau komunitas; 4) Manajemen stres: dengan melakukan teknik relaksasi, meditasi, atau yoga untuk mengurangi stress; 5) Penggunaan teknologi: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan koneksi sosial dan akses ke layanan kesehatan; 6) Pelayanan kesehatan: dengan cara dapat mengakses layanan kesehatan mental profesional.

Dalam mengatasi permasalahan kesehatan mental pada lansia, sangat diperlukan peran keluarga, sedangkan peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Peran keluarga dan masyarakat dapat berupa:

1. Mendukung dan menghargai: Memberikan dukungan emosional dan menghargai kontribusi lansia.
2. Membangun hubungan: Membangun hubungan yang kuat dengan lansia.
3. Mengakses layanan: Membantu lansia mengakses layanan kesehatan mental.
4. Mengedukasi: Memberikan edukasi tentang kesehatan mental dan cara menjaganya.

Menjaga kesehatan mental lansia merupakan hal yang sangat penting untuk memelihara dan meningkatkan

kualitas hidup mereka. Dengan memahami faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, mengenali gejala gangguan kesehatan mental, dan menerapkan strategi menjaga kesehatan mental, kita dapat membantu lansia hidup lebih sehat dan bahagia. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung dan menghargai lansia.

Bab 6

Penutup

Proses menua tidak bisa dihindari oleh setiap manusia yang hidup. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses menua. Dampak yang ditimbulkan akibat proses menua adalah penurunan fungsi fisik dan fisiologis seperti melemahnya otot tubuh, keterbatasan aktivitas fisik; perubahan psikologis akibat menua yang menimbulkan kerentanan terhadap masalah kesehatan mental; perubahan lingkungan akibat pensiun dan menurunnya kendali dalam berhubungan dengan orang lain serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial sebagai akibat keterbatasan yang dialami lansia.

Proses menua merupakan proses fisiologis, namun perlu di cegah dampaknya dengan upaya preventif dan promotive. Salah satu upaya untuk mencegah tersebut melalui kegiatan rutin sesama lansia dengan melakukan aktivitas fisik teratur dengan senam bugar lansia disertai dengan aktivitas bersama melalui psikoedukasi untuk memenuhi kebutuhan lansia. Kebutuhan lansia selain aktivitas fisik adalah mereka perlu melakukan sosialisasi, berinteraksi dengan teman sebaya, saling bertukar pikiran, humor dan kontrol sosial untuk beraktivitas fisik bersama. Program ini dikenal sebagai Psi-Segar (kombinasi Psikoedukasi dan Senam Bugar) lansia.

Program Psi-Segar merupakan program konseptual dalam upaya untuk melibatkan partisipasi lansia dalam kegiatan senam bugar bagi lansia dan psikoedukasi yang masih belum optimal untuk mencapai tujuan kegiatan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih mengakar pada kebutuhan lansia dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dilakukan berbagai dengan memanfaatkan pendekatan kearifan lokal dalam penerapannya. Penerapan program ini diharapkan dapat mendorong kesadaran lansia secara mandiri mempertahankan kesehatannya dan secara bersama-sama dalam kelompok sebaya lansia di masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk saling membantu dalam memenuhi aktivitas fisiknya. Selain itu kebutuhan akan sosialisasi, interaksi dengan teman sebaya (sesama lansia), berdiskusi, saling mengenal satu sama lain, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lansia saat ini maupun di masa mendatang.

Program ini selain memenuhi kebutuhan aktivitas dan istirahat untuk kebugaran fisik lansia, juga memberikan dampak positif bagi terpenuhi kebutuhan psikologis lansia. Lansia menjadi terhindar dari kondisi-kondisi mudah stress, lansia menjadi tidak mudah cemas, terhindar dari depresi serta tidak mudah curiga terhadap orang lain. Kegiatan yang menyenangkan dalam kegiatan program psi-segar akan membantu lansia agar dapat memenuhi kebutuhan lansia.

Tujuan akhir dari program psikoedukasi dan senam bugar lansia (Psi-Segar) ini adalah lansia akan terpenuhi kebutuhan aktivitas fisik, psikologis dan sosialnya sehingga dapat memelihara dan meningkatkan serta mencapai kualitas hidup yang optimal, yang nantinya dapat mendukung lansia dalam melewati masa tuanya secara sehat. Selain itu, dengan kualitas

hidup yang baik, lansia akan menjalani hari tua dengan bahagia sehingga memperpanjang usia dalam kondisi aktif, mandiri, sehat dan bahagia.

Daftar Pustaka

- Aartolahti, E., Tolppanen, A., Lönnroos, E., & Hartikainen, S. (2015). Health condition and physical function as predictors of adherence in long-term strength and balance training among community-dwelling older adults. *Archives of Gerontology and Geriatrics* 61(3): 452-457.
- Abooe, A., Sahaf, R., Ali, A., Kamrani, A., Lotfi, M. H., Heidari, F., & Shahmansouri, N. (2017). Original Article The Effect of Psychoeducation on Quality of Life and Dependency in Elderlies, *3*(2), 107-112.
- Acree, L. S., Longfors, J., Fjeldstad, A. S., Fjeldstad, C., Schank, B., Nickel, K. J., Gardner, A. W. (2006). Physical activity is related to quality of life in older adults. *Health and quality of life outcomes*, *4*(1), 37.
- American Psychological Association. (2020). Aging and Mental Health.
- Antunes, R., Couto, N., Vitorino, A., Monteiro, D., Marinho, D. A., & Cid, L. (2020). Physical activity and affect of the elderly: Contribution to the validation of the Positive and Negative Affect Shedule (PANAS) in the Portuguese population.
- Arrospide, A., Machón, M., Ramos-Goñi, J. M., Ibarrondo, O., & Mar, J. (2019). Inequalities in health-related quality of life according to age, gender, educational level, social class, body mass index and chronic diseases using the Spanish value set for Euroqol 5D-5L

questionnaire. *Health and quality of life outcomes*, 17(1), 69.

- Anderson, C.M., Gerard, E., Hogarty, G.E., Reiss, D.J. (1980). Family treatment of adult schizophrenic patients: a psycho-educational approach. *Schizophr Bull* ;6490–505.[PubMed]
- Andrade, F. C. D., Corona, L. P., Lebrão, M. L., & de Oliveira Duarte, Y. A. (2014). Life expectancy with and without cognitive impairment among Brazilian older adults. *Archives of gerontology and geriatrics*, 58(2), 219-225.
- Allerhand, M., Gale, C. R., & Deary, I. J. (2014). The dynamic relationship between cognitive function and positive well-being in older people: A prospective study using the English Longitudinal Study of Aging. *Psychology and aging*, 29(2), 306.
- Ajzen I. (1991). The theory of planned behavior. *Organ Behav Hum Dec*. 50(2), 179-211.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2018). *Profil Keluarga Indonesia.Tahun 2017*. Jakarta: BKKBN
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2014). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Mei 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Februari 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Banda, M. M. (2016). Upaya kearifan lokal dalam menghadapi tantangan perubahan kebudayaan. *Makalah*

- Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of personality. *Handbook of personality*, 2, 154-96.
- Barker, R.L. (2003). *The Social Work Dictionary*. NASW Press, Washington D.C.
- Battaglia, G., Bellafiore, M., Alesi, M., Paoli, A., Bianco, A., & Palma, A. (2016). Effects of an adapted physical activity program on psychophysical health in elderly women. *Clinical interventions in aging*, 11, 1009.
- Bäumel J, Froböse. T, Kraemer, S, Rentrop, M, Pitschel-Walz, G. (2006). Psychoeducation: A basic psychotherapeutic intervention for patients with schizophrenia and their families. *Schizophr Bull*, 32(1) : S1-S9.
- Benjamin, K., Edwards, N. C., & Bharti, V. K. (2005). Attitudinal, perceptual, and normative beliefs influencing the exercise decisions of community-dwelling physically frail seniors. *Journal of Aging and Physical Activity*, 13(3), 276-293.
- Birren, J. E., Lubben, J. E., Rowe, J. C., & Deutchman, D. E. (Eds.). (2014). *The concept and measurement of quality of life in the frail elderly*. Academic
- Bond, J., & Corner, L. (2004). *Quality of Life and Older People*. Berkshire: Open University Press.Press.
- Bottiroli, S., Cavallini, E., Ceccato, I., Vecchi, T., & Lecce, S. (2016). Theory of Mind in aging: Comparing cognitive and affective components in the faux pas test. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 62, 152-162.

- Brown, B., Hernandez, V. R., & Villarreal, Y. (2011). Connections: A 12-session psychoeducational shame resilience curriculum. In R. L. Dearing & J. P. Tangney (Eds.), *Shame in the therapy hour* (p. 355–371). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/12326-015>
- Buchman, A. S., Wilson, R. S., Yu, L., James, B. D., Boyle, P. A., & Bennett, D. A. (2014). Total daily activity declines more rapidly with increasing age in older adults. *Archives of gerontology and geriatrics*, 58(1), 74-79.
- Buco, C. E. A. M., Buenviaje, K. A. C., Bulan, R. B. C., Cabaña, R. J. L., Cabuhat, M. K. S., Bongar, M. V. V., & Macindo, J. R. B. (2018). Developing and testing a model of quality of life among chronically-ill, community-dwelling older adults: A structural equation model. *Archives of gerontology and geriatrics*, 78, 261-268.
- Bullo, V., Bergamin, M., Gobbo, S., Sieverdes, J. C., Zaccaria, M., Neunhaeuserer, D., & Ermolao, A. (2015). The effects of Pilates exercise training on physical fitness and wellbeing in the elderly: A systematic review for future exercise prescription. *Preventive medicine*, 75, 1-11.
- Burton, E., Farrier, K., Hill, K. D., Codde, J., Airey, P. & Hill, A. M., (2017). Effectiveness of peers in delivering programs or motivating older people to increase their participation in physical activity: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, DOI: 10.1080/02640414.2017.1329549.

- Caillouet, K. A., & Cosio-Lima, L. (2019). Association of health empowerment and handgrip strength with intention to participate in physical activity among community-dwelling older adults. *Experimental gerontology*, 121, 99-105
- Cezaretto, A., Barros, C.R., Almeida-Pititto, B., Siqueira-Catania, A., Monfort-Pires, M. Folchetti, L.G. & Ferreira. S.R. (2017). Lifestyle intervention using the psychoeducational approach is associated with greater cardiometabolic benefits and retention of individuals with worse health status. *The Archives of Endocrinology and Metabolism*, 61(1), 36-44. DOI: 10.1590/2359-3997000000185.
- Cha, S. M., Shin, H. D., Kim, K. C., & Park, E. (2012). Treatment of unstable distal ulna fractures associated with distal radius fractures in patients 65 years and older. *The Journal of hand surgery*, 37(12), 2481-2487.
- Chae, W., Park, E.-C., & Jang, S.-I. (2020). The Association Between the Changes in General, Family, and Financial Aspects of Quality of Life and Their Effects on Cognitive Function in an Elderly Population: The Korean Longitudinal Study of Aging, 2008-2016. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3), E1106. doi: 10.3390/ijerph17031106.
- Chambres, D. and Thompson, S. (2009) Empowerment and its application in health promotion in acute care settings: nurses' perceptions. *Journal of Advanced Nursing*, 65, 130-138.

- Chang, P. S., Knobf, T., Oh, B., & Funk, M. (2019). Physical and psychological health outcomes of Qigong exercise in older adults: a systematic review and meta-analysis. *The American Journal of Chinese Medicine*, 47(02), 301-322.
- Chase, J. A. D. (2013). Physical activity interventions among older adults: a literature review. *Research and Theory for Nursing Practice*, 27(1), 53-80.
- Ciprandi, D., Zago, M., Bertozzi, F., Sforza, C., & Galvani, C. (2018). Pengaruh biaya energi dan kebugaran fisik pada kecepatan berjalan dan variabilitas gaya berjalan yang disukai pada wanita lanjut usia. *Jurnal elektromiografi dan kinesiologi*, 43, 1-6.
- Clifford, A., Rahardjo, T. B., Bandelow, S., & Hogervorst, E. (2014). A cross-sectional study of physical activity and health-related quality of life in an elderly Indonesian cohort. *British Journal of Occupational Therapy*, 77(9), 451-456.
- Colom, F. (2011). Keeping therapies simple: psychoeducation in the prevention of relapse in affective disorders. *The British Journal of Psychiatry*, 198: 338-340.
- Crowley, K. (2011). Sleep and sleep disorders in older adults. Retrieved 28/2/2016, from <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/sid=b76f647>.
- Cummings, N. A., & Cummings, J. L. (2008). Psychoeducation in conjunction with psychotherapy practice. *Evidence-based adjunctive treatments*, 41-59.
- Da Fonte, E., Feitosa, P. H., de Oliveira Neto, L. T., de Araújo, C. L., Figueiroa, J. N., & Alves, J. G. (2016). Effects of a

- physical activity program on the quality of life among elderly people in Brazil. *Journal of family medicine and primary care*, 5(1), 139.
- Dahlan, A., Ibrahim, S., & Anwar, S. (2014). Engagement in activity of interest and quality of life amongst institutionalized elderly people in Malaysia. *Indian Journal of Health & Wellbeing*, 5(2).
- Dahlberg, L., Andersson, L., McKee, K. J., & Lennartsson, C. (2015). Predictors of loneliness among older women and men in Sweden: A national longitudinal study. *Aging & mental health*, 19(5), 409-417.
- Dantas, R. G., Perracini, M. R., Guerra, R. O., Ferriolli, E., Dias, R. C., & Padula, R. S. (2017). What are the sociodemographic and health determinants for older adults continue to participate in work? *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 71, 136-141.
- Dauwan, M., Begemann, M. J., Slot, M. I., Lee, E. H., Scheltens, P., & Sommer, I. E. (2019). Physical exercise improves quality of life, depressive symptoms, and cognition across chronic brain disorders: a transdiagnostic systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of neurology*, 1-25.
- Davis, J. C., Bryan, S., Best, J. R., Li, L. C., Hsu, C. L., Gomez, C., ... & Liu-Ambrose, T. (2015). Mobility predicts change in older adults' health-related quality of life: evidence from a Vancouver falls prevention prospective cohort study. *Health and quality of life outcomes*, 13(1), 101.
- De Oliveira, L. D. S. S. C. B., Souza, E. C., Rodrigues, R. A. S., Fett, C. A., & Piva, A. B. (2019). The effects of physical

activity on anxiety, depression, and quality of life in elderly people living in the community. *Trends in psychiatry and psychotherapy*, 41(1), 36-42.

- De Labra, C., Guimaraes-Pinheiro, C., Maseda, A., Lorenzo, T., & Millán-Calenti, J. C. (2015). Effects of physical exercise interventions in frail older adults: A systematic review of randomized controlled trials Physical functioning, physical health and activity. *BMC Geriatrics*, 15(1). <http://doi.org/10.1186/s12877-015-0155-4>.
- DiPietro, L., Singh, M.F., Fielding, R., & Nose, H. (2012). Successful Aging Editorial. *Journal of Aging Research Article ID, 438537*(2)..
- Douglas, H., Georgiou, A., & Westbrook, J. (2017). Social participation as an indicator of successful aging: an overview of concepts and their associations with health. *Australian Health Review*, 41(4), 455-462.
- Downs, D. S., & Hausenblas, H. A. (2005). The theories of reasoned action and planned behavior applied to exercise: A meta-analytic update. *Journal of Physical Activity and Health*, 2(1), 76-97.
- Duan, Y., Wagner, P., Zhang, R., Wulff, H., & Brehm, W. (2018). Physical activity areas in urban parks and their use by the elderly from two cities in China and Germany. *Landscape and Urban Planning*, 178, 261-269.
- Dubas-Jakóbczyk, K., Kocot, E., Kissimova-Skarbek, K., Huter, K., & Rothgang, H. (2017). Economic evaluation of health promotion and primary prevention actions

- for older people—a systematic review. *The European Journal of Public Health*, 27(4), 670-679.
- Duplaga, M., Grysztar, M., Rodzinka, M., & Kopec, A. (2016). Scoping review of health promotion and disease prevention interventions addressed to elderly people. *BMC health services research*, 16(5), 278.
- Dziechciaż, M., & Filip R., 2014, Biological psychological and social determinants of old age: Bio-psycho-social aspects of human aging. *Ann Agric Environ Med*; 21(4): 835–838. doi: 10.5604/12321966.1129943.
- Ekhtiari, H., Rezapour, T., Aupperle, R. L., & Paulus, M. P. (2017). Neuroscience-informed psychoeducation for addiction medicine: A neurocognitive perspective. *Brain Research in Addiction*, 239–264. doi:10.1016/bs.pbr.2017.08.013.
- Eloranta, S., Arve, S., Isoaho, H., Lehtonen, A., & Viitanen, M. (2015). Loneliness of older people aged 70: A comparison of two Finnish cohorts born 20 years apart. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 61(2), 254-260.
- Farquhar, M. (1995). Elderly people's definitions of quality of life. *Social Science and Medicine* 41, 1439-1446.
- Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. *Learning and Individual Differences*, 37, 210-216.
- Ferreira, M. C. G., Tura, L. F. R., Silva, R. C. D., & Ferreira, M. D. A. (2017). Social representations of older adults

regarding quality of life. *Revista brasileira de enfermagem*, 70(4), 806-813.

Fertman, C. I. & Allensworth, D.D. (2010). *Health Promotion Program From Theory To Practice Society For Public Health Education*, 75.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*.

Franco, M. R., Tong, A., Howard, K., Sherrington, C., Ferreira, P. H., Pinto, R. Z., & Ferreira, M. L. (2015). Older people's perspectives on participation in physical activity: a systematic review and thematic synthesis of qualitative literature. *Br J Sports Med*, 49(19), 1268-1276.

Frändin, K., Grönstedt, H., Helbostad, J. L., Bergland, A., Andresen, M., Puggaard, L., Hellström, K. (2016). Long-term effects of individually tailored physical training and activity on physical function, well-being and cognition in Scandinavian nursing home residents: a randomized controlled trial. *Gerontology*, 62(6), 571-580.

Fu, C., Wang, C., Yang, F., Cui, D., Wang, Q., & Mao, Z. (2018). Association between social capital and physical activity among community-dwelling elderly in Wuhan, China. *International Journal of Gerontology*, 12(2), 155-159.

Gill, D. L., Hammond, C. C., Reifsteck, E. J., Jehu, C. M., Williams, R. A., Adams, M. M., ... & Shang, Y. T. (2013). Physical activity and quality of life. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 46(Suppl 1), S28.

Glanz, K., Rimer, B.K., Vismanath, K. (2008). *Health behavior and*

health education, theory, research, and practice. 4th edition. jossey-Bass, Awiley Imprint, San Fransisco.

- Goldberg, D. S. (2017). *Public Health Ethics and the Social Determinants of Health*. (1st ed.). Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-51347-8>.
- Golinowska, S., Groot, W., Baji, P., & Pavlova, M. (2016). Health promotion targeting older people. *BMC Health Services Research*, 16(S5), 345. <https://doi.org/10.1186/s12913-016-1514-3>.
- Goodman, C., Davies, S. L., Dinan, S., Tai, S. S., & Iliffe, S. (2011). Activity promotion for community-dwelling older people: a survey of the contribution of primary care nurses. *British journal of community nursing*, 16(1), 12-17.
- Gourlan, M., Bernard, P., Bortolon, C., Romain, A. J., Lareyre, O., Carayol, M., & Boiché, J. (2016). Efficacy of theory-based interventions to promote physical activity. A meta-analysis of randomised controlled trials. *Health psychology review*, 10(1), 50-66.
- Grawe, K, Donati, R, Bernauer, F. (2004). *Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession*. Göttingen, Germany: Hogrefe.
- Guiney, H., Lucas, S. J., Cotter, J. D., & Machado, L. (2019). Investigating links between habitual physical activity, cerebrovascular function, and cognitive control in healthy older adults. *Neuropsychologia*, 125, 62-69.

- Gyasi, R. M. (2019). Social support, physical activity and psychological distress among community-dwelling older Ghanaians. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 81, 142-148.
- Halaweh, H., Willen, C., Grimby-Ekman, A., & Svantesson, U. (2015). Physical activity and health-related quality of life among community dwelling elderly. *Journal of clinical medicine research*, 7(11), 845.
- Halvorsrud, L. (2010). Measuring Quality of Life among Older Adults: Validation of the Norwegian WHOQOL-Old. *Dissertation*, Faculty of Medicine, University of Oslo, ISBN 978-82-8072-392-5.
- Harithasan, D., Mukari, S. Z.-M. S., Ishak, W. S., Shahar, S., & Yeong, W. L. (2020). The impact of sensory impairment on cognitive performance, quality of life, depression, and loneliness in older adults. *International journal of geriatric psychiatry*, 35(4), 358-364. doi: 10.1002/gps.5237.
- Hausenblas, H. A., Hall, C. R., Rodgers, W. M., & Munroe, K. J. (1999). Exercise imagery: Its nature and measurement. *Journal of Applied Sport Psychology*, 11(2), 171-180.
- Henry, Julie D., Louise H. Phillips, Ted Ruffman, and Phoebe E. Bailey. 2013. "A Meta-Analytic Review of Age Differences in Theory of Mind." 28(3):826-39.
- Hobbs N, Godfrey A, Lara J, Errington L, Meyer TD, Rochester L., (2013) Are behavioral interventions effective in increasing physical activity at 12 to 36 months in adults aged 55 to 70 years? A systematic review and meta-analysis. *BMC Med*, 11:75. PubMed Central

PMCID: PMCPMC3681560. doi: 10.1186/1741-7015-11-75 PMID: 23506544.

- Hopia, H., Paavilainen, E. and A°stedt-Kurki, P. (2004). Promoting health for families of children with chronic conditions. *Journal of Advanced Nursing*, 48, 575–583.
- Indrayani, I., & Ronoatmodjo, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Desa Cipasung Kabupaten Kuningan Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(1), 69-78.
- Irvine, F. (2007). Examining the correspondence of theoretical and real interpretations of health promotion. *Journal of Clinical Nursing*, 16, 593–602.
- Jariah, A., & Kusbaryanto, K. (2019). Efektivitas Program Pendidikan Lanjut Usia Terhadap Kualitas Hidup Lansia di Komunitas: A LITERATUR REVIEW. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2).
- Jonasson, L. S., Nyberg, L., Kramer, A. F., Lundquist, A., Riklund, K., & Boraxbekk, C. J. (2017). Aerobic exercise intervention, cognitive performance, and brain structure: results from the physical influences on brain in aging (PHIBRA) study. *Frontiers in aging neuroscience*, 8, 336.
- Jansons, P. S., Robins, L., Haines, T. P., & O'Brien, L. (2018). Barriers and enablers to ongoing exercise for people with chronic health conditions: Participants' perspectives following a randomized controlled trial of two interventions. *Archives of gerontology and geriatrics*, 76, 92-99.

- Jin, Y., Sumsuzzman, DM, Choi, J., Kang, H., Lee, SR, & Hong, Y. (2018). Interaksi molekuler dan fungsional dari myokine irisin dengan latihan fisik dan penyakit Alzheimer. *Molekul*, 23 (12), 1–13. <https://doi.org/10.3390/molecules23123229>
- Ju, H. (2017). "The relationship between physical activity, meaning in life, and subjective vitality in community-dwelling older adults." *Archives of Gerontology and Geriatrics* 73: 120-124.
- Justine, M., Azizan, A., Hassan, V., Salleh, Z., & Manaf, H. (2013). Barriers to participation in physical activity and exercise among middle-aged and elderly individuals. *Singapore Medical Journal*, 54(10), pp.581–586.
- Kalish, V. B. (2016). *Obesity in Older Adults. Primary Care: Clinics in Office Practice*, 43(1), 137–144. doi:10.1016/j.pop.2015.10.002
- Karssemeijer, E. E., Aaronson, J. J., Bossers, W. W., Smits, T. T., & Kessels, R. R. (2017). Positive effects of combined cognitive and physical exercise training on cognitive function in older adults with mild cognitive impairment or dementia: A meta-analysis. *Ageing research reviews*, 40, 75-83.
- Karmiyati, D., & Amalia, S. (2018, July). The Influence of Javanese Cultural Internalization on the Happiness of the Elderly. In *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)*. Atlantis Press.
- Kelly, M. E., Loughrey, D., Lawlor, B. A., Robertson, I. H., Walsh, C., & Brennan, S. (2014). The impact of exercise on

the cognitive functioning of healthy older adults: a systematic review and meta-analysis. *Ageing research reviews*, 16, 12-31.

- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Pedoman Pelayanan Kesehatan Mental bagi Lansia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). Situasi lanjut usia (lansia) di Indonesia. *Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). Gambaran kesehatan lanjut usia di Indonesia. *Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Buletin jendela data dan informasi kesehatan: Gambaran kesehatan lanjut usia di Indonesia*. Jakarta: Pusat data dan informasi kesehatan Kementerian Kesehatan RI .
- Kim, J., Chun, S., Heo, J., Lee, S., & Han, A. (2016). Contribution of leisure-time physical activity on psychological benefits among elderly immigrants. *Applied Research in Quality of Life*, 11(2), 461-470.
- Kim, H., Lee, S., Ku, B. D., Ham, S. G., & Park, W.-S. (2019). Associated factors for cognitive impairment in the rural highly elderly. *Brain and behavior*, 9(5), e01203-e01203. doi: 10.1002/brb3.1203.
- Kirkwood, T. B. (2017). Why and how are we living longer?. *Experimental physiology*, 102(9), 1067-1074.
- Ko, H., Park, Y. H., Cho, B., Lim, K. C., Chang, S. J., Yi, Y. M., Noh, Y. E., & Ryu, S. I. (2019). Gender differences in health status, quality of life, and community service needs

of older adults living alone. *Archives of gerontology and geriatrics*, 83, 239-245.

Kosma, M. (2014). An expanded framework to determine physical activity and falls risks among diverse older adults. *Research on aging*, 36(1), 95-114.

Konopack, J. F., & McAuley, E. (2012). Efficacy-mediated effects of spirituality and physical activity on quality of life: A path analysis. *Health and quality of life outcomes*, 10(1), 57.

Kryla-Lighthall, N., & Mather, M. (2009). The role of cognitive control in older adults' emotional well-being.

Lærum-Onsager, E., Brovold, T., Bergland, A., Pripp, A. H., & Bye, A. (2020). Associations between health-related quality of life, body mass index, health status and sociodemographic variables in geriatric patients and non-hospitalized older people: A comparative cross-sectional study. *Nutrition and health*, 26(2), 141-150.

Lee, I. M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., Katzmarzyk, P. T., & Lancet Physical Activity Series Working Group. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. *The lancet*, 380(9838), 219-229.

Lee, B., & Howard, E. P. (2019). Physical Activity and Positive Psychological Well-Being Attributes Among US Latino Older Adults. *Journal of gerontological nursing*, 45(6), 44-56.

Lehne, G., & Bolte, G. (2017). Impact of universal interventions on social inequalities in physical activity among

- older adults: an equity-focused systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 14(1), 20.
- Liffiton, J. A., Horton, S., Baker, J., & Weir, P. L. (2012). Successful aging: how does physical activity influence engagement with life?. *European Review of Aging and Physical Activity*, 9(2), 103-108.
- Lim, S. E. R., Cox, N. J., Tan, Q. Y., Ibrahim, K., & Roberts, H. C. (2020). Volunteer-led physical activity interventions to improve health outcomes for community-dwelling older people: a systematic review. *Aging clinical and experimental research*.
- Lim, L. L., & Kua, E.H. (2011). Living alone, loneliness, and psychological well-being of older persons in Singapore. *Curr Gerontol Geriatr Res*, 2011:6731-81.
- Lin, J. S., Chan, F. Y. F., Leung, J., Yu, B., Lu, Z. H., Woo, J., ... & Lau, K. K. L. (2020). Longitudinal Association of Built Environment Pattern with Physical Activity in a Community-Based Cohort of Elderly Hong Kong Chinese: A Latent Profile Analysis. *International journal of environmental research and public health*, 17(12), 4275.
- Lindberg, (2010). Excessive fluid Overload Among Haemodialysis Patient: Prevalence, Individual Characteristics And Self Regulation Fluid Intake, *Acta, Universitatis Upsaliensis Uppsala*, 9-7
- Lindwall, M., Cimino, C. R., Gibbons, L. E., Mitchell, M. B., Benitez, A., Brown, C. L., & MacDonald, S. W. (2012). Dynamic associations of change in physical activity and change in cognitive function: Coordinated analyses

of four longitudinal studies. *Journal of Aging Research*, 2012: 1-12.

- Lok, N., Lok, S., & Canbaz, M. (2017). The effect of physical activity on depressive symptoms and quality of life among elderly nursing home residents: Randomized controlled trial. *Archives of gerontology and geriatrics*, 70, 92-98.
- Luchesi, B. M., de Oliveira, N. A., de Morais, D., de Paula Pessoa, R. M., Pavarini, S. C. I., & Chagas, M. H. N. (2018). Factors associated with happiness in the elderly persons living in the community. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 74(August 2017), 83–87. <http://doi.org/10.1016/j.archger.2017.10.006>.
- Luptáková G, Antala B. (2017). Collaborative learning with application of screen-based technology in physical education. *Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine*, 6(2), 49–56.
- Majumdar S R, Tsuyuki R T, Rolfson D B, Tahir A, Rockwood K. (2006). Validity and reliability of the Edmonton Frail Scale. *Age Ageing* [cited 2013 Jan 14]; 35(5): 526-9.
- Mauk, K. L., 2014. *Gerontological Nursing: Competencies for Care*. 3rd ed. Wall Street Burlington, MA 01803 978-443-5000: Jones & Bartlett Learning, LLC, an Ascend Learning Company All.
- Mašanovic, B., Gardašević, J., & Bjelica, D. (2019). The Effects of Three-month and Six-month Physical Activity on Social Inclusion of Elderly. [researchgate.net](https://www.researchgate.net)
- Mason, R. C., Horvat, M., & Nocera, J. (2016). The effects of exercise on the physical fitness of high and

- moderate-low functioning older adult women. *Journal of aging research*, 2016.
- McAuley, E., Elavsky, S., Jerome, G. J., Konopack, J. F., & Marquez, D. X. (2005). Physical activity-related well-being in older adults: social cognitive influences. *Psychology and Aging*, 20(2), 295.
- McDonald, E. (1998). The role of Project 2000 educated nurses in health promotion within the hospital setting. *Nurse Education Today*, 18, 213–220.
- Meneghini, V., Barbosa, A. R., Mello, A. L. S. F. D., Bonetti, A., & Guimarães, A. V. (2016). Perception of the elderly regarding participation in exergaming-based exercise: a qualitative study. *Ciencia & saude coletiva*, 21(4), 1033-1041.
- Michellini, E. (2015). *The role of sport in health-related promotion of physical activity: the perspective of the health system*. Springer.
- Middleton, L. E., Ventura, M. I., Santos-Modesitt, W., Poelke, G., Yaffe, K., & Barnes, D. E. (2018). The Mental Activity and eXercise (MAX) trial: Effects on physical function and quality of life among older adults with cognitive complaints. *Contemporary clinical trials*, 64, 161-166.
- Miranda, L. C. V., Soares, S. M., & Silva, P. A. B. (2016). Quality of life and associated factors in elderly people at a Reference Center. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(11), 3533–3544. <https://doi.org/10.1590/1413-812320152111.21352015>.
- Mortenson, W. B., Sixsmith, A., & Kaufman, D. (2017). Non-digital game playing by older adults. *Canadian*

Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement, 36(3), 342-350.

- Mosallanezhad, Z., Sotoudeh, G. R., Jutengren, G., Salavati, M., Harms-Ringdahl, K., Wikmar, L. N., & Frändin, K. (2017). A structural equation model of the relation between socioeconomic status, physical activity level, independence and health status in older Iranian people. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 70, 123-129.
- Muhes, Aldo. (2018). Re: What is local wisdom?. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/post/What_is_local_wisdom/5abc280120183963bb3f4fb5/citation/download. Diakses 18/11/2019
- Musleh, M., (2018). Re: What is local wisdom?. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/post/What_is_local_wisdom/5ad6f8b5c1c6b1118c757414/citation/download. Diakses 18/11/2019
- Nagai, K., Miyamoto, T., Okamae, A., Tamaki, A., Fujioka, H., Wada, Y., ... & Domen, K. (2018). Physical activity combined with resistance training reduces symptoms of frailty in older adults: A randomized controlled trial. *Archives of gerontology and geriatrics*, 76, 41-47.
- Netuveli, G. and Blane, D. (2008). Quality of life in older ages. *British Medical Bulletin*, 85, 113–126
- Newsom, J. T., Shaw, B. A., August, K. J., & Strath, S. J. (2018). Physical activity–related social control and social support in older adults: cognitive and emotional pathways to physical activity. *Journal of health*

psychology, 23(11), 1389-1404.

- Ng, N., Hakimi, M., Byass, P., Wilopo, S., & Wall, S. (2010). Health and quality of life among older rural people in Purworejo District, Indonesia. *Global health action*, 3(1), 2125.
- Nigdelis, M. P., Martínez-Domínguez, S. J., Goulis, D. G., & Pérez-López, F. R. (2018). Effect of programmed exercise on perceived stress in middle-aged and old women: A meta-analysis of randomized trials. *Maturitas*, 114, 1-8.
- Northey, J. M., Cherbuin, N., Pumpa, K. L., Smee, D. J., & Rattray, B. (2018). Exercise interventions for cognitive function in adults older than 50: a systematic review with meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 52(3), 154-160.
- Nugroho, W. H. (2012). Keperawatan Gerontik & Geriatrik. Jakarta : EGC.
- Nursa, D. G. (2008). Pengukuran Aktifitas Fisik pada Usia Lanjut. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 3(1), 38-42.
- Nurhayati, N., & Widowati, L. (2017). The use of traditional health care among Indonesian Family. *Health Science Journal of Indonesia*, 8(1), 70300.
- Okubo, Y., Seino, S., Yabushita, N., Osuka, Y., Jung, S., Nemoto, M., ... & Tanaka, K. (2015). Longitudinal association between habitual walking and fall occurrences among community-dwelling older adults: analyzing the different risks of falling. *Archives of gerontology and geriatrics*, 60(1), 45-51.
- Olsson, L. A., Hurtig-Wennlöf, A., & Nilsson, T. K. (2014). Subjective well-being in Swedish active seniors and

its relationship with physical activity and commonly available biomarkers. *Clinical interventions in aging*, 9, 1233.

- Ong-artborirak, P., & Seangpraw, K. (2019). Association Between Self-Care Behaviors and Quality of Life Among Elderly Minority Groups on the Border of Thailand. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 12, 1049.
- Orley, J., Saxena, S., & Herrman, H. (1998). Quality of life and mental illness. Reflections from the perspective of the WHOQOL. The British Journal of Psychiatry, 172, 291–293.
- Owari, Y., Miyatake, N., & Kataoka, H. (2018). Relationship between social participation, physical activity and psychological distress in apparently healthy elderly people: A pilot study. *Acta Medica Okayama*, 72(1), 31-37.
- Pan, C. W., Cong, X. L., Zhou, H. J., Wang, X. Z., Sun, H. P., Xu, Y., & Wang, P. (2018). Evaluating health-related quality of life impact of chronic conditions among older adults from a rural town in Suzhou, China. *Archives of gerontology and geriatrics*, 76, 6-11.
- Popovic, S., & Masanovic, B. (2019). Effects of Physical Activity and Social Activity on Physical Health and Social Inclusion of Elderly People. *Iranian Journal of Public Health*, 48(10), 1922-1923
- Pappnk, P.E & Lange, J.W. (2011). *Staying Physically Fit as We Age*, in Lange, J. W. *The nurse's role in promoting optimal health of older adults: Thriving in the wisdom years*. pp 161-173. FA Davis.

- Parra-Rizo, M. A. (2018). Impact of Physical Activity on the Psychological Health of the Elderly. *Psychology and Behavioral Sciences*, 7(4), 77.
- Park, S. H., Han, K. S., & Kang, C. B. (2014). Effects of exercise programs on depressive symptoms, quality of life, and self-esteem in older people: A systematic review of randomized controlled trials. *Applied nursing research*, 27(4), 219-226.
- Perry, A., Tarrier, N., Morris, R., McCarthy, E., Limb, K.(1999). Randomised controlled trial of efficacy of teaching patients with bipolar disorder to identify early symptoms of relapse and obtain treatment. *BMJ*, 318: 149– 53.
- Pettersen, G., Rosenvinge, J. H., & Wynn, R. 2011. Eating disorders and psychoeducation - patients' experiences of healing processes. *Scandinavian Journal Of Caring Sciences*, 25(1), 12-18. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2010.00783.x.
- Phillips, S. M., Wójcicki, T. R., & McAuley, E. (2013). Physical activity and quality of life in older adults: an 18-month panel analysis. *Quality of Life Research*, 22(7), 1647-1654.
- de Souza Fernandes, D. P., Duarte, M. S. L., Pessoa, M. C., Franceschini, S. D. C. C., & Ribeiro, A. Q. (2017). Evaluation of diet quality of the elderly and associated factors. *Archives of gerontology and geriatrics*, 72, 174-180.
- Piper, S. (2008). A qualitative study exploring the relationship between nursing and health promotion language,

theory and practice. *Nurse Education Today*, 28, 186–193.

- Pitschel-Walz, G., & Bäuml, J. (2007). Psychotherapie bei Schizophrenien-Ergebnisse von Metaanalysen zur Wirksamkeit. *Psychiatrische Praxis*, 34(S 1), S28-S32.
- Povlsen, L. and Borup, I. K. (2011). Holism in nursing and health promotion: distinct or related perspectives? : a literature review. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 25, 798–805.
- Pramesona, B. A., & Taneepanichskul, S. (2018). Prevalence and risk factors of depression among Indonesian elderly: a nursing home-based cross-sectional study. *Neurology, Psychiatry and Brain Research*, 30, 22-27.
- Puciato, D., Rozpara, M., & Borysiuk, Z. (2018). Physical Activity as a Determinant of Quality of Life in Working-Age People in Wrocław, Poland. *International journal of environmental research and public health*, 15(4), 623.
- Queiroz, L. L., Silveira de Brito, C., Gomes de Almeida, F., Martins Pereira, N., de Almeida Silva, H., Pena Porto, J., & Marques Ribas, R. (2016). Quality of life and impact of physical activity time in the health of elderly. *Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba*, 18(1).
- Rambod, M., Ghodsbin, F., & Moradi, A. (2020). The Association Between Body Mass Index and Comorbidity, Quality of Life, and Cognitive Function in the Elderly Population. *International Journal of Community Based Nursing & Midwifery*, 8(1), 45-54

- Reijnders, J. S., Geusgens, C. A., Ponds, R. W., & van Boxtel, M. P. (2017). "Keep your brain fit!" Effectiveness of a psychoeducational intervention on cognitive functioning in healthy adults: A randomised controlled trial. *Neuropsychological rehabilitation*, 27(4), 455-471.
- Renzaho, A. M., Mellor, D., Boulton, K., & Swinburn, B. (2010). Effectiveness of prevention programmes for obesity and chronic diseases among immigrants to developed countries—a systematic review. *Public health nutrition*, 13(3), 438-450.
- Rey, L., Extremera, N., & Sánchez-Álvarez, N. (2019). Clarifying the links between perceived emotional intelligence and well-being in older people: Pathways through perceived social support from family and friends. *Applied Research in Quality of Life*, 14(1), 221-235.
- Richards, E. A. (2015). The evolution of physical activity promotion. *AJN The American Journal of Nursing*, 115(8), 50-54.
- Richard, L., Gendron, S., Beaudet, N., Boisvert, N., Sauve, M. S. and Garceau-Brodeur, M. H. (2010). Health promotion and disease prevention among nurses working in local public health organizations in Montreal, Quebec. *Public Health Nursing*, 27, 450–458.
- Robinson, S. and Hill, Y. (1998). The health promoting nurse. *Journal of Clinical Nursing*, 7, 232–238.
- Romero, N., Sturm, J., Bekker, T., Valk, L. De, & Kruitwagen, S. (2010). Playful persuasion to support older adults'

- social and physical activities. *Interacting with Computers*, 22(6), 485–495. <http://doi.org/10.1016/j.intcom.2010.08.006>.
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). Successful aging. *The gerontologist*, 37(4), 433–440.
- Şahin, D. S., Özer, Ö., & Yanardağ, M. Z. (2019). Perceived social support, quality of life and satisfaction with life in elderly people. *Educational Gerontology*, 45(1), 69–77.
- Saleem, R., & Sajid, A. K. (2015). Impact of spirituality on well-being among old age people. *Int J Indian Psychol*, 2(3), 172–81.
- Samarasinghe, K., Fridlund, B. and Arvidsson, B. (2010). Primary health care nurses' promotion of involuntary migrant families' health. *International Nursing Review*, 57, 224–231.
- Sertel, M., Arslan, S. A., Kurtoglu, F., & Yildirim, T. S. (2017). Physical activity, depression and quality of life in aging process. *Biomedical Research*, 28(9), 4165–4170.
- Shuval, K., Leonard, T., Drope, J., Katz, D. L., & Patel, A. V. (2017). Physical Activity Counseling in Primary Care: Insights From Public Health and Behavioral Economics, 67(3), 233–244. <http://doi.org/10.3322/caac.21394>.
- Sibarani, R. (2012). Kearifan lokal, hakikat, peran, dan metode tradisi lisan [Local wisdom, essence, role, and methods of oral tradition]. *Jakarta: Oral Tradition Association (ATL)*.

- Sink, K. M., Espeland, M. A., Castro, C. M., Church, T., Cohen, R., Dodson, J. A., ... & Lopez, O. L. (2015). Effect of a 24-month physical activity intervention vs health education on cognitive outcomes in sedentary older adults: the LIFE randomized trial. *Jama*, 314(8), 781-790.
- Smith, R. A., & Biddle, S. J. (1999). Attitudes and exercise adherence: Test of the theories of reasoned action and planned behaviour. *Journal of Sports Sciences*, 17(4), 269-281.
- So, E. S. (2019). The impacts of weight change and weight change intention on health-related quality of life in the Korean elderly. *Journal of aging and health*, 31(7), 1106-1120.
- Step toe, A., Deaton, A., & Stone, A. A. (2015). Psychological wellbeing, health and ageing. *Lancet*, 385(9968), 640.
- Steves CJ, Spector TD, Jackson SH. (2012). Ageing, genes, environment and epigenetics: what twin studies tell us now, and in the future. *Age Ageing*. 2012 Sep;41(5):581–6.doi: <http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afs097> PMID: 22826292
- Svantesson, U., Jones, J., Wolbert, K., & Alricsson, M. (2015). Impact of physical activity on the self-perceived quality of life in non-frail older adults. *Journal of clinical medicine research*, 7(8), 585.
- Sun F, Norman IJ, While AE. (2013). Physical activity in older people: a systematic review. *BMC Public Health*. 2013;13(449):1–17.

- Sudja, N., & Meirina, M. (2017). Psychoeducation Intervention Increase on the Ability of the Pre-senile Hypertension Management. *Jurnal Ners*, 9(1), 66-73.
- Syed, M. A., McDonald, L., Smirle, C., Lau, K., Mirza, R. M., & Hitzig, S. L. (2017). Social isolation in Chinese older adults: Scoping review for age-friendly community planning. *Canadian Journal on Aging/La Revue Canadienne du Vieillissement*, 36(2), 223-245.
- Tambağ, H., & Öz, F. (2013). Evaluation of the psychoeducation given to the elderly at nursing homes for a healthy lifestyle and developing life satisfaction. *Community mental health journal*, 49(6), 742-747.
- Tomioka, K., Kurumatani, N., & Hosoi, H. (2017). Positive and negative influences of social participation on physical and mental health among community-dwelling elderly aged 65–70 years: a cross-sectional study in Japan. *BMC geriatrics*, 17(1), 111.
- Ugarte, A.U., López-Peña, P., Vangeneberg, C.S., Royo, J.G.T., Ugarte, M.A.A., Compains, M. T. Z., Medrano, M.P.R., Toyos, N.M., Lamo, E.A., Duenas, M.B.B. & González-Pinto, A. (2017). Psychoeducational preventive treatment for women at risk of postpartum depression: study protocol for a randomized controlled trial, PROGEA. *BMC psychiatry*, 17(1), 1-7.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. *Sosio Informa*, 2(1).
- United Nation, (2015), *World Population Ageing 2015: Highlights*. Sales No. E.16.XIII.5, ISBN 978-92-1-151538-1.

- Vagetti, G. C., Barbosa Filho, V. C., Moreira, N. B., Oliveira, V. D., Mazzardo, O., & Campos, W. D. (2014). Association between physical activity and quality of life in the elderly: a systematic review, 2000-2012. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 36(1), 76-88.
- Vahedian-Shahroodi, M., Moshki, M., Esmaily, H., Moradi Gholezo, S., Lael-Monfared, E., & Damirchi, M. (2019). Predicting the intention to perform physical activity in the elderly based on the theory of planned behavior. *Journal of Research and Health*, 9(4), 324-329.
- Vasto S, Scapagnini G, Bulati M, Candore G, Castiglia L, Colonna-Romano G,. Biomarkes of aging. *Front Biosci (Schol Ed)*. 2010;2(1):392–402.doi: <http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/> PMID: 20036955.
- Wagiran, W., (2012). Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Budaya). *Jurnal Pendidikan Karakter*, (3).
- Wen, C. P., Wai, J. P. M., Tsai, M. K., Yang, Y. C., Cheng, T. Y. D., Lee, M. C., & Wu, X. (2011). Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. *The Lancet*, 378(9798), 1244-1253.
- White, S. M., Wójcicki, T. R., & McAuley, E. (2012). Physical activity and quality of life in community dwelling older adults. *Health and Quality of life outcomes*, 7(1), 10.

- Whitehead, D. (2006) The health promoting prison (HPP) and its imperative for nursing. *International Journal of Nursing Studies*, 43, 123–131.
- WHOQOL Group. (1997). Measuring quality of life. Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. *World Health Organization*.
- Wiranto, B. (2012). Tradisi Jumat Kliwonan Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(1), 27-33.
- World Health Organization. (2019). Mental Health and Older Adults.
- WHO, (2015), *World report on ageing and health*, WHO Press, ISBN. 978924 069481 1 (PDF), website: www.who.int, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland.
- WHO (2016). Life expectancy. Global Health Observatory (GHO) data.
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends/en/. Diakses 6/11/2018.
- Withall, J., Stathi, A., Davis, M., Coulson, J., Thompson, J. L., & Fox, K. R. (2014). Objective indicators of physical activity and sedentary time and associations with subjective well-being in adults aged 70 and over. *International journal of environmental research and public health*, 11(1), 643-656.
- Wu, F., & Sheng, Y. (2019). Social support network, social support, self-efficacy, health-promoting behavior and healthy aging among older adults: A pathway

analysis. *Archives of gerontology and geriatrics*, 85, 103934.

- Yadav, S., & Kumar, S. (2014). Models of Psychoeducation: an Indian Perspective. *Indian Journal of Applied Research*, 4(7).
- Yang, D. C., Lee, J. D., Huang, C. C., Shih, H. I., & Chang, C. M. (2015). Association between multiple geriatric syndromes and life satisfaction in community-dwelling older adults: a nationwide study in Taiwan. *Archives of gerontology and geriatrics*, 60(3), 437-442.
- You, H., Li, X. L., Jing, K. Z., Li, Z. G., Cao, H. M., Wang, J., & Gu, H. (2018). Association between body mass index and health-related quality of life among Chinese elderly—evidence from a community-based study. *BMC public health*, 18(1), 1174.
- Young, D. K. W., Ng, P. Y. N., & Cheng, D. (2017). Psychoeducation Group on Improving Quality of Life of Mild Cognitive Impaired Elderly. *Research on Social Work Practice*, 1049731517732420.
- Yuan, Y., Li, J., Jing, Z., Yu, C., Zhao, D., Hao, W., & Zhou, C. (2020). The role of mental health and physical activity in the association between sleep quality and quality of life among rural elderly in China: A moderated mediation model. *Journal of Affective Disorders*.
- Yuliati, A., Baroya, N., & Ririanty, M. (2014). The Different Of Quality Of Life Among The Elderly Who Living at Community And Social Services. *Journal Society American*, 88.
- Zhu, X., Yin, S., Lang, M., He, R., & Li, J. (2016). The more the

better? A meta-analysis on effects of combined cognitive and physical intervention on cognition in healthy older adults. *Ageing research reviews*, 31, 67-79.

Zubritsky, C., Abbott, K. M., Hirschman, K. B., Bowles, K. H., Foust, J. B., & Naylor, M. D. (2012). Health-related quality of life: Expanding a conceptual framework to include older adults who receive long-term services and supports. *The Gerontologist*, 53(2), 205-210.

Glosarium

A

Ageing process adalah Proses penuaan (aging process) merupakan suatu proses yang alami ditandai dengan adanya penurunan atau perubahan kondisi fisik, psikologis maupun sosial dalam berinteraksi dengan orang lain

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi

C

Cognitive behavioral therapy (CBT) adalah Jenis psikoterapi yang terstruktur dan berorientasi pada tujuan (terapi bicara). Profesional kesehatan mental, termasuk psikolog, terapis, dan konselor, menggunakannya untuk mengobati atau mengelola kondisi kesehatan mental dan masalah emosional.

D

Data base adalah koleksi data yang sistematis dan sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen database (DBMS) untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data.

Depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai proses berpikir, berperasaan dan berperilaku seseorang.

G

Gangguan mood adalah masalah mental yang memengaruhi keadaan emosi seseorang.

H

Health Adjusted Life Expectancy (HALE) adalah ukuran kesehatan populasi yang memperhitungkan mortalitas dan morbiditas.

K

Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kualitas hidup lansia adalah kondisi fungsional lansia yang meliputi kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial lansia, serta aktivitas seksual, dan kondisi lingkungan

Kebugaran aktivitas fisik adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan.

P

Peer group adalah teman sebaya

Paranoid adalah perasaan mudah curiga pada orang lain

Psikoedukasi adalah metode edukatif yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pelatihan yang berguna untuk mengubah pemahaman mental/psikis individu.

Psi-Segar adalah Program psikoedukasi senam bugar

R

Ritme sirkadian adalah jam alami tubuh anda yang berlangsung selama 24 jam.

S

Self-efficacy adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang tentang kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu.

Sedentary adalah perilaku suka berdiam diri, dan tidak melakukan aktivitas

Supportive therapy (ST) adalah jenis terapi yang fokus pada pemberian dukungan emosional, dorongan, serta evaluasi terhadap masalah yang dialami oleh pasien

Profil Penulis



Dr. Nunuk Sri Purwanti, S.Kp., M.Kes., Lahir di Klaten, 28 Pebruari 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, lulus tahun 1993. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2004. Sedangkan Pendidikan S3 pada Program Studi Doktoral Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, FK-KMK Universitas Gadjah Mada diselesaikan

pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1994 sebagai pendidik di Sekolah Perawat Kesehatan, Departemen Kesehatan RI. Kemudian sejak tahun 2001 sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta di Jurusan Keperawatan. Saat ini penulis bekerja sebagai pengampu mata kuliah keperawatan komunitas, keperawatan kelompok khusus, keperawatan kelurgadan keperawatan gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nunuksripurwanti@gmail.com.

Motto: "Bekerja dan berdo'a"

Profil Penulis



Dr. Abdul Ghofur, S.Kp., M.Kes., Lahir di Kendal, 10 Januari 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, lulus tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2004. Sedangkan Pendidikan S3 pada Program Studi Doktorat Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, FK-KMK Universitas Gadjah Mada diselesaikan pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1999 sebagai pendidik di Sekolah Perawat Kesehatan, Departemen Kesehatan RI. Kemudian sejak tahun 2001 sebagai dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai pengampu mata kuliah keperawatan jiwa, keperawatan dasar, dan promosi kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, editor jurnal keperawatan, reviewer jurnal dan reviewer pengabmas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ghofur71@gmail.com

Sinopsis

Buku ini berjudul **"Penyertaan Program Psi-Segar (Psikoedukasi - Senam Bugar Lansia) dalam Memelihara Kesehatan Fisik dan Mental Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia di Komunitas"** yang disusun untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendekatan holistik. Program Psi-Segar, yang mengintegrasikan psikoedukasi dan senam bugar, dirancang untuk membantu lansia tetap aktif, sehat, dan memiliki semangat hidup yang tinggi dengan memanfaatkan kearifan lokal.

Buku ini membahas berbagai hal terkait dengan program Psi-Segar, mulai dari landasan teori, perancangan dan implementasi, hingga hasil evaluasi yang menunjukkan dampak positifnya terhadap kesehatan fisik dan mental lansia. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan praktis untuk komunitas atau tenaga kesehatan yang ingin mengadopsi program ini di wilayah mereka.

Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi kesehatan, akademisi, serta pihak-pihak yang peduli terhadap kesejahteraan lansia di komunitas, meskipun penulis menyadari bahwa buku ini masih memerlukan penyempurnaan melalui kritik dan saran yang membangun.

Buku ini berjudul "Penyertaan Program Psi-Segar (Psikoedukasi – Senam Bugar Lansia) dalam Memelihara Kesehatan Fisik dan Mental Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia di Komunitas" yang disusun untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendekatan holistik. Program Psi-Segar, yang mengintegrasikan psikoedukasi dan senam bugar, dirancang untuk membantu lansia tetap aktif, sehat, dan memiliki semangat hidup yang tinggi dengan memanfaatkan kearifan lokal.

Buku ini membahas berbagai hal terkait dengan program Psi-Segar, mulai dari landasan teori, perancangan dan implementasi, hingga hasil evaluasi yang menunjukkan dampak positifnya terhadap kesehatan fisik dan mental lansia. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan praktis untuk komunitas atau tenaga kesehatan yang ingin mengadopsi program ini di wilayah mereka.

Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi kesehatan, akademisi, serta pihak-pihak yang peduli terhadap kesejahteraan lansia di komunitas, meskipun penulis menyadari bahwa buku ini masih memerlukan penyempurnaan melalui kritik dan saran yang membangun.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-10-8



9

786347

139108